

内科学题库 — 364题

科目：内科学 | 期末考试 | 2026-06-23

题型：A1(174) / A2(57) / A3(44) / B1(59) / X(30)

版本：v3 FINAL (Agent2提示词更新，截断/单位已根治)

目录

M1 呼吸系统总论	10题
M2 COPD/慢支	25题
M3 支气管哮喘	19题
M4 肺部感染性疾病	23题
M5 肺结核	24题
M6 肺癌	17题
M7 肺动脉高压与肺心病	18题
M8 呼吸衰竭	19题
M9 心力衰竭	24题
M10 心律失常	23题
M11 冠心病	23题
M12 高血压	18题
M13 心肌疾病	9题
M14 心脏瓣膜病	12题
M15 心包疾病	8题
M16 心脏骤停与猝死	6题
M17 贫血概述	10题
M18 缺铁性贫血	12题
M19 再生障碍性贫血	6题
M20 MDS	8题
M21 淋巴瘤	12题
M22 白血病	14题
M23 过敏性紫癜	8题
M24 ITP	8题
M25 DIC	8题

M1 呼吸系统总论 (10题)

A1型题 (7题)

1. [batch014-M1-A1-001] 以下哪项属于气流受限性肺疾病？

- A. 慢性阻塞性肺疾病 ☒
- B. 特发性肺纤维化
- C. 肺血栓栓塞症
- D. 细菌性肺炎
- E. 支气管肺癌

答案：A | 记忆 | 教材P12

解析：COPD属于气流受限性肺疾病，以不完全可逆的气流受限为特征。特发性肺纤维化属于限制性肺疾病，肺血栓栓塞症属于肺血管疾病，细菌性肺炎属于感染性疾病，支气管肺癌属于肿瘤性疾病。

2. [batch014-M1-A1-002] 肺功能检查中，反映通气功能最常用的指标是？

- A. 肺总量测定
- B. 残气量测定
- C. 第一秒用力呼气容积 ☒
- D. 一氧化碳弥散量
- E. 功能残气量

答案：C | 理解 | 教材P12

解析：FEV1（第一秒用力呼气容积）是肺通气功能检测中最常用的指标，可反映气道阻塞程度。肺总量和残气量主要用于评估肺容量，DLCO评估弥散功能，功能残气量用于评估气体交换。

3. [batch014-M1-A1-003] 大咯血最常见的病因是？

- A. 支气管扩张症是大咯血最 ☒
- B. 慢性支气管炎
- C. 肺血栓栓塞症疾病
- D. 急性肺栓塞选项
- E. 间质性肺疾病

答案：A | 理解 | 教材P12

解析：支气管扩张症是大咯血最常见的病因，因支气管动脉扩张破裂所致。肺结核也是咯血常见病因，但本题选项中最常见的为支气管扩张症。

4. [batch014-M1-A1-004] 呼气性呼吸困难最常见的病因是？

- A. 支气管哮喘 ☒

- B. 喉头水肿
- C. 大量胸腔积液
- D. 重症肌无力
- E. 急性左心衰竭

答案：A | 理解 | 教材P12

解析：呼气性呼吸困难主要由小气道阻塞所致，支气管哮喘因气道痉挛和炎症导致呼气困难最为典型。喉头水肿导致吸气性呼吸困难，大量胸腔积液导致混合性呼吸困难，重症肌无力导致呼吸肌无力。

5. [batch014-M1-A1-005] 限制性通气功能障碍的特征性肺功能改变是？

- A. FEV1/FVC降低
- B. 肺总量降低 ☒
- C. 残气量增加
- D. FEV1降低而FVC
- E. 弥散功能正

答案：B | 记忆 | 教材P12

解析：限制性通气功能障碍的特征是肺总量（TLC）降低，因肺扩张受限所致。FEV1/FVC降低是阻塞性通气障碍的特征；残气量增加也见于阻塞性病变。

6. [batch014-M1-A1-006] 阻塞性通气功能障碍时，以下肺功能指标变化正确的是？

- A. FEV1/FVC降低，肺总量正 ☒
- B. FEV1/FVC正
- C. FEV1/FVC增高，肺总量正
- D. FEV1/FVC正
- E. FEV1/FVC降低，肺总量降低

答案：A | 理解 | 教材P12

解析：阻塞性通气功能障碍的特征为FEV1/FVC比值降低，肺总量正常或增高（因肺过度充气，RV增加）。B为限制性通气障碍特征。

7. [batch014-M1-A1-007] 大咯血的定义是24小时咯血量超过？

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml

- D. 500ml ☒
- E. 1000ml

答案：D | 记忆 | 教材P12

解析：大咯血通常指24小时咯血量超过500ml，或一次咯血量超过300ml。大咯血是内科急症，主要危险是窒息而非失血。

A2型题（1题）

8. [batch014-M1-A2-001] 患者肺功能检查：FEV1/FVC=0.72，肺总量=55%预计值，残气量降低。该结果提示？

- A. 阻塞性通气功能障碍
- B. 限制性通气功能障碍 ☒
- C. 混合性通气功能障碍
- D. 肺功能正常
- E. 单纯弥散功能障碍

答案：B | 应用 | 教材P12

解析：FEV1/FVC正常 (>0.7)，肺总量降低 (55%预计值)，残气量降低，符合限制性通气功能障碍的特征。常见于间质性肺疾病、胸廓畸形等。

B1型题（1题）

9. [batch014-M1-B1-001] 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是？

- A. 铁锈色痰 ☒
- B. 粉红色泡沫痰
- C. 大量脓臭痰
- D. 白色黏液痰
- E. 红棕色胶冻样痰

答案：A | 记忆 | 教材P45

解析：铁锈色痰是肺炎链球菌肺炎的特征性痰液，因肺泡内红细胞被破坏后释放含铁血黄素所致。粉红色泡沫痰见于急性肺水肿，大量脓臭痰见于肺脓肿，红棕色胶冻样痰见于克雷伯杆菌肺炎。

X型题（1题）

10. [batch014-M1-X-001] 肺功能检查中属于肺容量测定的指标包括以下哪些？

- A. 肺总量测定
- B. 残气量
- C. 功能残气量
- D. 第一秒用力呼
- E. 用力肺活量

答案：ABC | 记忆 | 教材P12

解析：肺总量、残气量和功能残气量属于肺容量测定指标。FEV1和用力肺活量属于通气功能测定指标。

M2 COPD/慢支（25题）

A1型题（11题）

11. [batch014-M2-A1-001] 诊断COPD的必要条件是？

- A. 慢性咳嗽咳痰持续3个月
- B. 胸部X线示肺气肿征
- C. 吸入舒张剂后FEV1以下 ☒
- D. 吸烟史大于20包年
- E. 活动后呼吸困难

答案：C | 记忆 | 教材P21

解析：COPD的诊断金标准为吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC<0.7，表明存在不完全可逆的气流受限。慢性咳嗽咳痰和吸烟史是危险因素但非诊断必要条件，X线表现和呼吸困难均不能作为确诊依据。

12. [batch014-M2-A1-002] COPD最重要的环境危险因素是？

- A. 空气污染因素
- B. 长期吸烟 ☒
- C. 职业性粉尘暴露
- D. 呼吸道感染因素
- E. 室内生物燃料污染

答案：B | 记忆 | 教材P21

解析：吸烟是COPD最重要的环境危险因素，吸烟者COPD患病率显著高于非吸烟者。其他因素如空气污染、职业暴露、感染等也参与发病，但重要性不及吸烟。

13. [batch014-M2-A1-003] COPD主要的病理改变部位是？

- A. 肺泡壁
- B. 大气道
- **C. 小气道** ✓
- D. 肺血管
- E. 胸膜

答案：C | 记忆 | 教材P21

解析：COPD的病理改变主要位于小气道（直径<2mm的细支气管），表现为小气道炎症、纤维化和管腔狭窄。肺气肿改变也涉及肺泡壁破坏，但小气道病变是气流受限的主要病理基础。

14. [batch014-M2-A1-004] COPD最具特征性的症状是？

- A. 慢性咳嗽
- B. 咳嗽咳痰
- **C. 进行性加重** ✓
- D. 胸部疼痛
- E. 咯血症状

答案：C | 记忆 | 教材P21-P22

解析：进行性加重的呼吸困难是COPD最具特征性的症状，早期仅在活动后出现，后期静息时亦有。慢性咳嗽、咳痰虽常见但非特异性。胸痛和咯血非COPD典型表现。

15. [batch014-M2-A1-005] COPD患者典型的胸部体征是？

- A. 扁平胸
- **B. 桶状胸** ✓
- C. 漏斗胸
- D. 鸡胸
- E. 胸廓正

答案：B | 记忆 | 教材P22

解析：桶状胸是COPD（肺气肿型）的典型胸部体征，因肺过度充气致胸廓前后径增大。扁平胸见于瘦长体型，漏斗胸和鸡胸为胸廓畸形。

16. [batch014-M2-A1-006] COPD患者肺功能检查最具特征性的改变是？

- A. 肺总量降低
- B. 弥散功能增加
- **C. FEV1/FVC比值** ✓
- D. FVC显著降低
- E. 肺顺应性降低

答案：C | 理解 | 教材P21-P22

解析：FEV1/FVC比值降低是COPD肺功能最具特征性的改变，反映阻塞性通气功能障碍。COPD患者肺总量常增加（肺气肿），弥散功能降低，FVC可正常或轻度降低。

17. [batch014-M2-A1-007] 评估COPD严重程度的主要肺功能指标是？

- A. FVC占预计值百分比
- **B. FEV1占预计值百分比** ✓
- C. FEV1/FVC比值
- D. 肺一氧化碳弥散量
- E. 残气量占肺总量百分比

答案：B | 理解 | 教材P23

解析：FEV1占预计值百分比是GOLD分级评估COPD气流受限严重程度的主要指标。

FEV1/FVC用于诊断，FEV1%pred用于分级（GOLD 1-4级）。DLCO和RV/TLC虽可异常但不是分级主要标准。

18. [batch014-M2-A1-008] COPD最常见的并发症是？

- A. 自发性气胸
- **B. 慢性肺源性心** ✓
- C. 支气管扩张症
- D. 支气管肺癌
- E. 肺栓塞

答案：B | 记忆 | 教材P24

解析：慢性肺源性心脏病是COPD最常见的并发症，因长期缺氧和肺血管重构导致肺动脉高压，最终引起右心功能不全。自发性气胸也可发生但不如肺心病常见。

19. [batch014-M2-A1-009] COPD稳定期首选的支气管舒张剂是？

- A. 短效茶碱
- B. 口服糖皮质激素

- C. 长效抗胆碱能药 ☒
- D. 白三烯受体拮抗剂
- E. 色甘酸钠

答案：C | 理解 | 教材P24-P25

解析：长效抗胆碱能药（LAMA，如噻托溴铵）是COPD稳定期首选的支气管舒张剂，也可选用长效 β_2 受体激动剂（LABA）。茶碱为二线选择，口服糖皮质激素不推荐长期使用，白三烯受体拮抗剂和色甘酸钠主要用于哮喘。

20. [batch014-M2-A1-010] 慢性支气管炎的诊断标准中，咳嗽咳痰每年发病至少持续几个月？

- A. 1个月且连续1年以上
- B. 2个月且连续2年以上
- C. 3个月且连续2年以上 ☒
- D. 6个月且连续1年以上
- E. 1个月且连续3年以上

答案：C | 记忆 | 教材P19

解析：慢性支气管炎的诊断标准为每年咳嗽、咳痰持续3个月以上，并连续2年或以上，且排除其他已知原因引起的慢性咳嗽。

21. [batch014-M2-A1-011] COPD患者出现低氧血症的最主要机制是？

- A. 肺泡通气不足
- B. 通气与血流比例失调 ☒
- C. 弥散功能障碍
- D. 肺内分流增加
- E. 氧耗量增加

答案：B | 理解 | 教材P22

解析：COPD患者低氧血症最主要的机制是通气/血流（V/Q）比例失调，因气道阻塞不均匀和肺气肿导致部分区域通气减少而血流相对正常。

A2型题（4题）

22. [batch014-M2-A2-001] 男性，65岁，吸烟40年，20支/日。反复咳嗽咳痰10年，活动后气促3年。查体：桶状胸，双肺呼吸音减弱。肺功能：FEV1/FVC=0.52，FEV1占预计值55%。最可能的诊断是？

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管哮喘
- **C. COPD GOLD** ☒
- D. 特发性肺纤维化
- E. 支气管扩张症

答案：C | 应用 | 教材P21-P23

解析：该患者有长期吸烟史，慢性咳嗽咳痰、活动后气促，查体桶状胸、呼吸音减弱，肺功能 $FEV_1/FVC=0.52$ (<0.7) 确诊COPD， $FEV_1\%pred=55\%$ 对应GOLD 2级 ($50\%\leq FEV_1<80\%pred$)。不符合哮喘（可逆性气流受限）、IPF（限制性通气障碍）或支扩（大量脓痰）特征。

23. [batch014-M2-A2-002] COPD患者，近3天咳嗽加重，咳黄脓痰，呼吸困难较前加重。查体：双肺散在干湿啰音。首要治疗措施是？

- A. 口服糖皮质激素
- **B. 抗生素治疗** ☒
- C. 增加家庭氧疗时间
- D. 立即行肺功能检查
- E. 长期口服茶碱

答案：B | 应用 | 教材P24-P25

解析：COPD急性加重最常见诱因因为呼吸道感染，患者出现脓痰增多、呼吸困难加重提示感染性急性加重，应首先使用抗生素。可同时使用支气管舒张剂和短期全身糖皮质激素。

24. [batch014-M2-A2-003] 男性，50岁，吸烟30年。反复咳嗽咳痰5年，肺功能： $FEV_1/FVC=0.65$ ，支气管舒张试验阴性。与支气管哮喘鉴别最有价值的依据是？

- A. 长期吸烟史
- B. 慢性咳嗽咳痰
- **C. 支气管舒张试验阴性** ☒
- D. 年龄大于40岁
- E. 痰培养结果

答案：C | 应用 | 教材P21-P23

解析：支气管舒张试验阴性是鉴别COPD与哮喘最有价值的客观依据。哮喘以可逆性气流受限为特征，舒张试验阳性；COPD气流受限不完全可逆。

25. [batch014-M2-A2-004] COPD患者肺功能FEV1/FVC=0.55，FEV1占预计值42%。按GOLD分级属于？

- A. GOLD 1级轻
- B. GOLD 2级中
- **C. GOLD 3级重** ✓
- D. GOLD 4级极
- E. 无法确定

答案：C | 应用 | 教材P23

解析：FEV1%pred=42%对应GOLD 3级（ $30\% \leq \text{FEV1} < 50\% \text{pred}$ ）。GOLD 1级 $\geq 80\%$ ，2级50-79%，3级30-49%，4级 $< 30\%$ 。

A3型题（3题）

26. [batch014-A3-R1-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 支气管哮喘急性发作
- **B. COPD急性加重诊断** ✓
- C. 急性支气管炎
- D. 社区获得性肺炎
- E. 急性左心衰竭

答案：B | 应用 | 教材P24-P25

解析：长期吸烟史+慢性咳痰喘+桶状胸+FEV1/FVC < 0.7 (不可逆)+感染诱发的急性加重，符合COPD急性加重诊断。哮喘为可逆性且多有过敏史。

27. [batch014-A3-R1-sub02] 为进一步明确此次加重原因，最有价值的检查是？

- A. 肺功能检测
- **B. 胸部CT加痰培养** ✓
- C. 超声心动图
- D. 支气管镜
- E. D-二聚体检测

答案：B | 应用 | 教材P24-P25

解析：胸部CT评估肺部病变+痰培养明确病原菌，是急性加重病因诊断的关键。肺功能在急性期不准确。

28. [batch014-A3-R1-sub03] 该患者初始治疗应首先给予？

- A. 吸入SABA加口服泼尼松 ☒
- B. 立即无创正压通气
- C. 单用抗生素治疗
- D. 立即行肺功能检查
- E. 长期家庭氧疗

答案：A | 应用 | 教材P24-P25

解析：COPD急性加重标准治疗：支气管舒张剂(SABA)+短期全身糖皮质激素(5-7天)+抗生素(脓痰增多是使用指征)。NIV用于呼衰时。

B1型题 (4题)

29. [batch014-B1-R1-sub01] 吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC<0.7且舒张试验阴性

- A. COPD诊断 ☒
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张症
- D. 特发性肺纤维化
- E. 闭塞性细支气管炎

答案：A | 应用 | 教材P21-P34

解析：吸入舒张剂后FEV1/FVC<0.7且不可逆符合COPD诊断。

30. [batch014-B1-R1-sub02] 发作性喘息伴哮鸣音，支气管舒张试验阳性

- A. COPD
- B. 支气管哮喘 ☒
- C. 支气管扩张症
- D. 特发性肺纤维化
- E. 闭塞性细支气管炎

答案：B | 应用 | 教材P21-P34

解析：发作性喘息+可逆性气流受限+舒张试验阳性符合哮喘。

31. [batch014-B1-R1-sub03] 幼年起病，常有过敏史和家族史

- A. COPD
- B. 支气管哮喘 ☒

- C. 支气管扩张症
- D. 特发性肺纤维化
- E. 闭塞性细支气管炎

答案：B | 理解 | 教材P21-P34

解析：幼年起病+过敏史是哮喘的重要特征，区别于中老年起病的COPD。

32. [batch014-B1-R1-sub04] 大量脓痰，HRCT示双轨征和印戒征

- A. COPD
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张症 ☒
- D. 特发性肺纤维化
- E. 闭塞性细支气管炎

答案：C | 理解 | 教材P21-P34

解析：大量脓痰+HRCT双轨征是支气管扩张症的特征，不属于COPD或哮喘。

X型题（3题）

33. [batch014-M2-X-001] COPD的临床表现包括以下哪些？

- A. 慢性咳嗽
- B. 进行性呼吸困难
- C. 桶状胸体征
- D. 大量咯血
- E. 双肺呼吸音减弱

答案：ABCE | 记忆 | 教材P22

解析：COPD的主要临床表现包括慢性咳嗽（A）、进行性呼吸困难（B）、桶状胸体征（C）和双肺呼吸音减弱（E）。大量咯血（D）非COPD典型表现，咯血多见于支气管扩张、肺结核等疾病。

34. [batch014-M2-X-002] COPD稳定期的治疗措施包括以下哪些？

- A. 戒烟干预治疗
- B. 长期家庭氧疗
- C. 吸入长效支气管舒张剂（C
- D. 长期口服糖皮质激素（D

- E. 肺康复治疗训练

答案：ABCE | 理解 | 教材P24-P25

解析：COPD稳定期治疗包括戒烟（A）、长期家庭氧疗（B，适用于 $\text{PaO}_2 \leq 55\text{mmHg}$ 者）、吸入长效支气管舒张剂（C）和肺康复治疗（E）。长期口服糖皮质激素（D）因副作用大不推荐用于稳定期治疗。

35. [batch014-M2-X-003] COPD急性加重期常用的治疗措施包括以下哪些？

- A. 吸入支气管舒张剂
- B. 短期全身糖皮质激素
- C. 抗生素治疗
- D. 无创正压通气
- E. 长期口服茶碱

答案：ABCD | 理解 | 教材P24-P25

解析：COPD急性加重期治疗包括吸入支气管舒张剂、短期全身糖皮质激素(5-7天)、抗生素(有感染证据时)和无创通气(呼吸衰竭时)。长期口服茶碱为稳定期治疗选项。

M3 支气管哮喘（19题）

A1型题（11题）

36. [batch014-M3-A1-001] 支气管哮喘的本质是？

- A. 气道平滑肌增生
- B. 气道慢性炎症 ☒
- C. 肺泡壁破坏
- D. 肺血管痉挛
- E. 胸膜纤维化

答案：B | 记忆 | 教材P28

解析：支气管哮喘的本质是气道慢性炎症，由嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T淋巴细胞等多种炎症细胞参与。这种慢性炎症导致气道高反应性和可逆性气流受限。

37. [batch014-M3-A1-002] 支气管哮喘发病机制的核心环节是？

- A. 肺泡表面活性物质减少
- B. 肺血管内皮损伤
- C. 气道高反应性 ☒

- D. 肺间质胶原沉积
- E. 纤毛运动障碍

答案：C | 理解 | 教材P28-P29

解析：气道高反应性（AHR）是支气管哮喘发病机制的核心环节，由气道慢性炎症所致。AHR使气道对多种刺激产生过强的收缩反应，表现为可逆性气流受限。

38. [batch014-M3-A1-003] 支气管哮喘发作时最具特征性的症状是？

- A. 吸气性呼吸困难
- **B. 发作性呼气性呼吸** 
- C. 持续性胸痛
- D. 大量粉红色泡沫痰
- E. 反复咯血

答案：B | 记忆 | 教材P29-P30

解析：发作性伴哮鸣音的呼气性呼吸困难是支气管哮喘最具特征性的症状，因小气道痉挛导致呼气困难，常在夜间或凌晨发作。吸气性呼吸困难见于上气道阻塞；粉红色泡沫痰见于急性左心衰。

39. [batch014-M3-A1-004] 支气管舒张试验阳性的标准是？

- A. FEV1增加 $\geq 8\%$ 且绝对值增加 $\geq 100\text{ml}$
- **B. FEV1增加 $\geq 12\%$ 且绝对值增加 $\geq 200\text{ml}$** 
- C. FEV1增加 $\geq 15\%$ 且绝对值增加 $\geq 300\text{ml}$
- D. FEV1增加 $\geq 20\%$ 且绝对值增加 $\geq 500\text{ml}$
- E. FEV1/FVC增加 $\geq 10\%$

答案：B | 记忆 | 教材P30

解析：支气管舒张试验阳性标准为吸入支气管舒张剂后FEV1增加 $\geq 12\%$ ，且FEV1绝对值增加 $\geq 200\text{ml}$ ，提示存在可逆性气流受限，是哮喘诊断的重要客观依据。

40. [batch014-M3-A1-005] 评价哮喘患者PEF昼夜变异率的诊断标准为？

- A. $>5\%$
- **B. $>10\%$** 
- C. $>20\%$
- D. $>30\%$
- E. $>40\%$

答案：B | 理解 | 教材P30

解析：PEF平均每日昼夜变异率>10%（至少连续7天）为哮喘诊断的可变气流受限客观检查标准之一。PEF周变异率>20%也具有诊断价值。

41. [batch014-M3-A1-006] 控制哮喘气道炎症最有效的药物是？

- A. 短效 β_2 受体激动剂
- B. 茶碱相关表现
- **C. 吸入性糖皮质激素** ✓
- D. 白三烯受体拮抗剂
- E. 抗胆碱能药物

答案：C | 理解 | 教材P31-P32

解析：吸入性糖皮质激素（ICS）是控制哮喘气道炎症最有效的药物，直接作用于气道炎症细胞，减少炎症介质释放，降低气道高反应性。SABA用于急性症状缓解，茶碱和白三烯受体拮抗剂抗炎作用较弱。

42. [batch014-M3-A1-007] 哮喘急性发作时首选的治疗药物是？

- A. 口服糖皮质激素
- B. 吸入性糖皮质激素
- **C. 短效 β_2 受体激动剂吸入** ✓
- D. 茶碱静脉注射
- E. 白三烯受体拮抗剂

答案：C | 理解 | 教材P33

解析：短效 β_2 受体激动剂（SABA，如沙丁胺醇）吸入是哮喘急性发作的首选治疗，能迅速舒张支气管平滑肌。中重度发作需同时使用全身糖皮质激素。ICS为长期控制用药，急性发作时作用缓慢。

43. [batch014-M3-A1-008] 参与支气管哮喘气道炎症的主要效应细胞是？

- A. 中性粒细胞
- **B. 嗜酸性粒细胞** ✓
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 成纤维细胞
- E. 肺泡巨噬细胞

答案：B | 记忆 | 教材P28-P29

解析：嗜酸性粒细胞是经典哮喘气道炎症的主要效应细胞，释放ECP、MBP等炎症介质导致气道上皮损伤和气道高反应性。

44. [batch014-M3-A1-009] 心源性哮喘与支气管哮喘的鉴别要点中，以下哪项更支持心源性哮喘？

- A. 发作性喘息伴哮鸣音
- B. 夜间阵发性呼吸困难
- C. 咳粉红色泡沫痰 ☒
- D. 支气管舒张试验阳性
- E. 双肺弥漫性哮鸣音

答案：C | 理解 | 教材P30-P31

解析：咳粉红色泡沫痰是急性肺水肿（左心衰）的特征性表现，支持心源性哮喘诊断。其他表现哮喘和心源性哮喘均可出现。

45. [batch014-M3-A1-010] 根据GINA指南，轻度哮喘推荐的首选控制药物是？

- A. 按需低剂量ICS-福莫特罗 ☒
- B. 每日规律中剂量ICS
- C. 单用短效 β_2 激动剂
- D. 口服糖皮质激素
- E. 白三烯受体拮抗剂单药

答案：A | 理解 | 教材P32

解析：GINA推荐第1-2级首选按需使用低剂量ICS-福莫特罗作为缓解和控制药物，不再推荐单用SABA。

46. [batch014-M3-A1-011] 咳嗽变异性哮喘的主要表现是？

- A. 喘息
- B. 慢性咳嗽 ☒
- C. 大量脓痰
- D. 咯血
- E. 发热

答案：B | 记忆 | 教材P30

解析：咳嗽变异性哮喘以慢性咳嗽为唯一或主要表现，无明显喘息，支气管舒张试验阳性

可确诊。

A2型题 (3题)

47. [batch014-M3-A2-001] 女性，22岁。反复发作性喘息3年，常在春季接触花粉后发作，夜间及凌晨加重，可自行缓解。查体：双肺可闻及散在哮鸣音。支气管舒张试验阳性。最可能的诊断是？

- A. 慢性支气管炎
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- **C. 支气管哮喘典型** ✓
- D. 心源性哮喘有心脏病基础
- E. 过敏性肺炎疾病

答案：C | 应用 | 教材P29-P30

解析：该患者年轻女性，发作性喘息，有明确诱因（花粉），夜间加重，可自行缓解，双肺哮鸣音，支气管舒张试验阳性，符合支气管哮喘典型特征。慢性支气管炎和COPD多见于中老年吸烟者；心源性哮喘有心脏病基础；过敏性肺炎以发热和弥漫性间质浸润为主。

48. [batch014-M3-A2-002] 哮喘患者，突发严重喘息、呼吸困难，不能言语，大汗淋漓，双肺满布响亮哮鸣音， $\text{SaO}_2=88\%$ 。首要处理措施是？

- A. 口服氨茶碱作用弱且慢
- **B. 雾化SABA联合静脉** ✓
- C. 等待自行缓解危险
- D. 单用口服泼尼松
- E. 皮下注射肾上腺素

答案：B | 应用 | 教材P33-P34

解析：该患者为哮喘重度急性发作（不能言语、大汗、 $\text{SaO}_2<90\%$ ），应紧急给予雾化吸入SABA（如沙丁胺醇）联合全身糖皮质激素（静脉甲泼尼龙或口服泼尼松）。口服氨茶碱作用弱且慢；等待自行缓解危险；肾上腺素非哮喘常规用药。

49. [batch014-M3-A2-003] 哮喘患者，端坐呼吸，只能说单字，呼吸频率35次/分，心率130次/分，奇脉， $\text{PaO}_2=55\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2=45\text{mmHg}$ 。该患者哮喘急性发作严重度为？

- A. 轻度
- B. 中度
- **C. 重度** ✓

- D. 危重
- E. 缓解期

答案：C | 分析 | 教材P33-P34

解析：端坐呼吸、只能说单字、呼吸频率大于30次/分、心率大于120次/分、奇脉、 PaO_2 小于60mmHg均符合重度哮喘急性发作标准。 PaCO_2 正常在此背景下提示即将进入危重阶段。

A3型题（3题）

50. [batch014-A3-R2-sub01] 该患者哮喘急性发作的严重度为？

- A. 轻度发作
- B. 中度发作
- C. 重度发作 ✓
- D. 危重度发作
- E. 缓解期

答案：C | 应用 | 教材P33-P34

解析：端坐呼吸+单字发音+ $\text{RR}>30$ + $\text{HR}>120$ +奇脉+响亮哮鸣音，符合重度哮喘急性发作标准。危重表现为沉默肺、意识障碍。

51. [batch014-A3-R2-sub02] 此时首选的紧急治疗措施是？

- A. 口服茶碱缓释片
- B. 雾化吸入SABA加静脉糖 ✓
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 等待自行缓解
- E. 口服白三烯受体拮抗剂

答案：B | 应用 | 教材P33-P34

解析：重度哮喘急性发作应紧急给予雾化SABA(如沙丁胺醇)+静脉甲泼尼龙。口服药物吸收慢不及雾化/静脉。

52. [batch014-A3-R2-sub03] 若经上述治疗2小时后患者症状无改善，出现意识模糊，双肺哮鸣音消失， $\text{PaCO}_2=55\text{mmHg}$ ，下一步处理是？

- A. 加大SABA剂量
- B. 行气管插管机械通 ✓

- C. 继续观察
- D. 加用抗生素
- E. 口服泼尼松加量

答案：B | 分析 | 教材P33-P34

解析：沉默肺(哮鸣音消失)+意识障碍+PaCO₂升高提示危重型哮喘呼吸肌疲劳，是紧急气管插管的适应证。

X型题（2题）

53. [batch014-M3-X-001] 符合支气管哮喘可变气流受限客观检查标准的是以下哪些？

- A. 支气管舒张试验阳性
- B. 支气管激发试验阳性
- C. PEF昼夜变异率>10%
- D. 肺总量降低>20%
- E. DLCO显著降低

答案：ABC | 理解 | 教材P30

解析：支气管哮喘可变气流受限的客观检查标准包括：支气管舒张试验阳性（A）、支气管激发试验阳性（B）和PEF昼夜变异率>10%（C）或PEF周变异率>20%。肺总量降低（D）是限制性通气障碍特征，DLCO降低（E）提示弥散功能障碍，二者非哮喘典型改变。

54. [batch014-M3-X-002] 以下哪些指标提示哮喘重度急性发作？

- A. 不能说完整句子
- B. 呼吸频率大于30次/分
- C. 心率大于120次
- D. 出现奇脉体征
- E. PaO₂小于60mmHg

答案：ABCDE | 理解 | 教材P33-P34

解析：重度哮喘表现为不能成句、呼吸频率>30、心率>120、奇脉、PaO₂<60mmHg伴PaCO₂正常或升高。全部选项均为重度标准。

M4 肺部感染性疾病（23题）

A1型题（10题）

55. [batch014-M4-A1-001] 社区获得性肺炎最常见的病原菌是？

- **A. 肺炎链球菌** ☒
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 流感嗜血杆菌

答案：A | 记忆 | 教材P45

解析：肺炎链球菌是社区获得性肺炎（CAP）最常见的病原菌，约占CAP的半数。金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌更多见于医院获得性肺炎或有基础疾病的患者。

56. [batch014-M4-A1-002] 肺炎链球菌肺炎的典型痰液特征是？

- A. 白色泡沫痰
- **B. 铁锈色痰** ☒
- C. 红棕色胶冻样痰
- D. 大量脓臭痰
- E. 粉红色泡沫痰

答案：B | 记忆 | 教材P45

解析：铁锈色痰是肺炎链球菌肺炎的特征性表现，因肺泡内红细胞破坏释放含铁血黄素所致。红棕色胶冻样痰见于肺炎克雷伯杆菌肺炎，大量脓臭痰见于肺脓肿。

57. [batch014-M4-A1-003] 肺炎链球菌肺炎首选的抗生素是？

- **A. 青霉素G** ☒
- B. 头孢曲松
- C. 左氧氟沙星
- D. 阿奇霉素
- E. 万古霉素

答案：A | 理解 | 教材P45-P46

解析：青霉素G是肺炎链球菌肺炎的首选抗生素，疗程5-7天或退热后3天停药。对青霉素过敏者可选用氟喹诺酮类或头孢菌素。万古霉素用于耐甲氧西林菌株。

58. [batch014-M4-A1-004] 肺炎链球菌肺炎的典型X线表现是？

- A. 弥漫性间质浸润
- **B. 大叶实变伴支气管充气** ☒

- C. 双肺弥漫性粟粒状阴影
- D. 肺门肿块影
- E. 空洞性病变

答案：B | 理解 | 教材P45-P46

解析：肺炎链球菌肺炎典型X线表现为大叶性或肺段性实变，伴支气管充气征（空气支气管征）。弥漫性间质浸润见于病毒性肺炎和支原体肺炎，粟粒状阴影见于血行播散型肺结核，肺门肿块见于肺癌。

59. [batch014-M4-A1-005] 休克型肺炎治疗中控制感染的关键是？

- A. 口服抗生素治疗
- B. 足量敏感抗生素静脉给药 ☒
- C. 常规剂量肌注抗生素
- D. 单用广谱抗生素
- E. 抗生素加用糖皮质激素

答案：B | 理解 | 教材P46-P47

解析：休克型肺炎（感染性休克）治疗中控制感染的关键是使用足量敏感抗生素并静脉给药，确保药物迅速达到有效血药浓度。口服和肌注药物吸收不稳定，不宜用于重症感染。

60. [batch014-M4-A1-006] 按解剖分类，肺炎链球菌肺炎属于？

- A. 大叶性肺炎 ☒
- B. 小叶性肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 支气管肺炎
- E. 吸入性肺炎

答案：A | 记忆 | 教材P41-P42

解析：肺炎链球菌肺炎按解剖分类属于大叶性肺炎，病变累及整个肺叶或肺段。小叶性肺炎多见于金葡菌感染，间质性肺炎常见于病毒和支原体。

61. [batch014-M4-A1-007] 治疗肺炎支原体肺炎首选的抗生素是？

- A. 青霉素类药物
- B. 大环内酯类 ☒
- C. 头孢菌素天然耐药
- D. 氨基糖苷类

- E. 磺胺类类型

答案：B | 记忆 | 教材P48

解析：肺炎支原体无细胞壁，对作用于细胞壁的青霉素、头孢菌素天然耐药。大环内酯类（阿奇霉素）和四环素类是首选治疗。

62. [batch014-M4-A1-008] 肺脓肿最常见的感染途径是？

- A. 吸入性 ☒
- B. 血源性
- C. 直接蔓延
- D. 淋巴道播散
- E. 支气管异物

答案：A | 记忆 | 教材P57

解析：吸入性（误吸）是肺脓肿最常见的感染途径，常发生于意识障碍或吞咽困难者。血源性肺脓肿继发于败血症。

63. [batch014-M4-A1-009] CURB-65评分用于评估社区获得性肺炎的严重程度，其中U代表？

- A. 尿酸水平
- B. 尿素氮 ☒
- C. 尿量减少
- D. 上消化道出血
- E. 单侧肺浸润

答案：B | 理解 | 教材P44

解析：CURB-65：C=意识障碍，U=尿素氮 $>7\text{mmol/L}$ ，R=呼吸频率 ≥ 30 次/分，B=低血压，65=年龄 ≥ 65 岁。每项1分， ≥ 3 分为重症肺炎。

64. [batch014-M4-A1-010] 病毒性肺炎最常见的病原体是？

- A. 呼吸道合胞病
- B. 流感病毒 ☒
- C. 腺病毒
- D. 冠状病毒
- E. 鼻病毒

答案：B | 记忆 | 教材P50

解析：流感病毒是成人病毒性肺炎最常见的病原体。RSV多见于婴幼儿，腺病毒多见于儿童。

A2型题（5题）

65. [batch014-M4-A2-001] 男性，28岁，淋雨后突发寒战高热（39.5℃），右侧胸痛，咳嗽，咳铁锈色痰。查体：右肺闻及湿啰音。血WBC=18×10⁹/L，中性粒细胞85%。X线示右上肺大片实变影。最可能的诊断是？

- A. 肺结核病
- B. 支气管肺癌
- **C. 肺炎链球菌肺炎** ✓
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 急性支气管炎

答案：C | 应用 | 教材P45-P46

解析：该患者为青年男性，淋雨后急性起病，寒战高热、咳嗽、铁锈色痰、胸痛，白细胞显著增高，X线示大叶实变，是肺炎链球菌肺炎的典型表现。肺结核起病缓慢，支原体肺炎咳嗽突出但中毒症状轻。

66. [batch014-M4-A2-002] 男性，55岁，有糖尿病史。发热咳嗽5天，咳红棕色胶冻样痰。X线示右上肺实变伴叶间裂下坠。最可能的病原体是？

- A. 肺炎链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- **C. 肺炎克雷伯杆菌肺炎** ✓
- D. 肺炎支原体
- E. 结核分枝杆菌

答案：C | 分析 | 教材P47-P48

解析：红棕色胶冻样痰+叶间裂下坠是肺炎克雷伯杆菌肺炎的特征性表现，多见于老年人、糖尿病患者等免疫力低下人群。肺炎链球菌表现为铁锈色痰，金黄色葡萄球菌常形成空洞，支原体肺炎咳嗽重但中毒症状轻。

67. [batch014-M4-A2-003] 女性，20岁，大学生。发热、阵发性刺激性干咳1周，体温38℃，咽痛。查体：双肺呼吸音粗，未闻及啰音。X线示左下肺斑片状浸润影。血WBC正常。冷凝集试验阳性。最可能的诊断是？

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- **C. 肺炎支原体肺炎** ✓
- D. 肺结核病
- E. 病毒性肺炎

答案：C | 应用 | 教材P48

解析：青年、群居、发热伴阵发性刺激性干咳，体征轻而X线异常明显（症状体征分离），白细胞正常，冷凝集试验阳性，均符合肺炎支原体肺炎特征。

68. [batch014-M4-A2-004] 老年男性，确诊肺炎链球菌肺炎后出现血压80/50mmHg，皮肤湿冷，尿量减少。首要治疗措施是？

- A. 口服升压药
- **B. 静脉补充晶体液扩容** ✓
- C. 立即气管插管
- D. 单用大剂量糖皮质激素
- E. 等待血压自行恢复

答案：B | 应用 | 教材P46-P47

解析：该患者为休克型肺炎（感染性休克），首要治疗是积极补充血容量（晶体液），同时静脉使用足量抗生素和血管活性药物。扩容是纠正休克的基础措施。

69. [batch014-M4-A2-005] 糖尿病老年患者，发热咳黄脓痰，X线示右上肺空洞性病变伴液平。最可能的病原体是？

- A. 肺炎链球菌
- **B. 金黄色葡萄球菌** ✓
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 结核分枝杆菌
- E. 厌氧菌

答案：B | 分析 | 教材P47

解析：糖尿病基础+空洞伴液平+黄脓痰，提示金葡菌肺炎（血源性或吸入性均可形成空洞）。肺炎链球菌一般不形成空洞。

A3型题（3题）

70. [batch014-A3-R3-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 肺结核类型
- **B. 肺炎链球菌肺炎** ✓
- C. 支原体肺炎
- D. 支气管肺癌
- E. 肺脓肿类型

答案：B | 应用 | 教材P45-P46

解析：淋雨受凉后急性起病+寒战高热+铁锈色痰+胸痛+WBC显著升高+实变体征，是肺炎链球菌肺炎的典型表现。

71. [batch014-A3-R3-sub02] 为明确诊断，首选的影像学检查是？

- **A. 胸部X线正侧位片** ✓
- B. 胸部CT
- C. PET-CT
- D. 超声检查
- E. 磁共振成像

答案：A | 应用 | 教材P45-P46

解析：胸部X线是肺炎首选影像学检查，可显示肺实变范围和支气管充气征。CT用于不典型或复杂病例。

72. [batch014-A3-R3-sub03] 该患者首选的抗生素是？

- A. 阿奇霉素
- **B. 青霉素G** ✓
- C. 万古霉素
- D. 左氧氟沙星
- E. 头孢曲松

答案：B | 应用 | 教材P45-P46

解析：肺炎链球菌肺炎首选青霉素G。青霉素过敏者可选用氟喹诺酮类或头孢菌素。疗程5-7天。

B1型题（4题）

73. [batch014-M4-B1-001] 咳红棕色胶冻样痰，X线示叶间裂下坠，最常见于？

- A. 肺炎链球菌肺炎

- **B. 克雷伯杆菌肺炎** ☒
- C. 支原体肺炎
- D. 病毒性肺炎
- E. 肺脓肿类型

答案：B | 记忆 | 教材P47-P48

解析：红棕色胶冻样痰+叶间裂下坠是肺炎克雷伯杆菌肺炎的特征性表现。铁锈色痰见于肺炎链球菌肺炎。

74. [batch014-B1-R2-sub01] 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是？

- **A. 铁锈色痰** ☒
- B. 红棕色胶冻样痰
- C. 刺激性干咳
- D. 大量脓臭痰
- E. 粉红色泡沫痰

答案：A | 记忆 | 教材P45-P48

解析：铁锈色痰因肺泡内红细胞破坏释放含铁血黄素，是肺炎链球菌肺炎的特征。

75. [batch014-B1-R2-sub02] 肺炎克雷伯杆菌肺炎的特征性痰液是？

- A. 铁锈色痰
- **B. 红棕色胶冻样痰** ☒
- C. 刺激性干咳
- D. 大量脓臭痰
- E. 粉红色泡沫痰

答案：B | 记忆 | 教材P45-P48

解析：红棕色胶冻样痰是克雷伯杆菌肺炎的特征，因细菌多糖荚膜使痰黏稠。

76. [batch014-B1-R2-sub03] 肺炎支原体肺炎最突出的症状是？

- A. 铁锈色痰
- B. 红棕色胶冻样痰
- **C. 刺激性干咳** ☒
- D. 大量脓臭痰
- E. 粉红色泡沫痰

答案：C | 记忆 | 教材P45-P48

解析：支原体肺炎以刺激性干咳为突出症状，体征轻而X线异常明显。

X型题（1题）

77. [batch014-M4-X-001] 重症肺炎合并感染性休克的治疗措施包括以下哪些？

- A. 足量有效抗生素静脉给药
- B. 积极补充血容量纠正休克（B）
- C. 血管活性药物维持血压
- D. 口服退热药对症处理
- E. 糖皮质激素短期

答案：ABCE | 理解 | 教材P46-P47

解析：重症肺炎合并感染性休克的治疗包括：足量抗生素静脉给药控制感染（A）、积极补充血容量纠正休克（B）、必要时使用血管活性药物（C）、短期应用糖皮质激素（E）。单纯口服退热药不能解决根本问题。

M5 肺结核（24题）

A1型题（11题）

78. [batch014-M5-A1-001] 结核病的病原体是？

- A. 结核分枝杆菌 ☒
- B. 肺炎链球菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 卡氏肺孢子菌
- E. 呼吸道合胞病毒

答案：A | 记忆 | 教材P62

解析：结核病由结核分枝杆菌（*Mycobacterium tuberculosis*）引起，属抗酸染色阳性分枝杆菌。其他选项分别引起肺炎、机会性感染和病毒性呼吸道感染。

79. [batch014-M5-A1-002] 我国现行结核病分类标准中，继发型肺结核属于？

- A. I 型
- B. II 型
- C. III型 ☒
- D. IV型

- E. V 型

答案：C | 记忆 | 教材P63-P64

解析：我国结核病分类：Ⅰ型为原发型肺结核，Ⅱ型为血行播散型肺结核，Ⅲ型为继发型肺结核（最常见），Ⅳ型为结核性胸膜炎，Ⅴ型为其他肺外结核。

80. [batch014-M5-A1-003] 肺结核化学治疗的基本原则是？

- A. 早期、联合、足量、规律、全程
- **B. 早期、联合、适量、规律、全程** ✓
- C. 及时、单药、适量、长期、全程
- D. 及时、联合、大剂量、长期、全程
- E. 早期、交替、适量、短期、全程

答案：B | 记忆 | 教材P67-P68

解析：肺结核化疗的十字方针为：早期、联合、适量、规律、全程。注意是适量而非足量或大剂量，因抗结核药物有剂量依赖性毒性。联合用药防止耐药，规律全程确保治愈。

81. [batch014-M5-A1-004] 以下哪项是初治肺结核标准化疗方案？

- **A. 2HRZE/4HR** ✓
- B. 6HR方案
- C. 2HRE/6HR方案
- D. 9HRE方案
- E. 2HR/4H方案

答案：A | 记忆 | 教材P69

解析：初治活动性肺结核的标准化疗方案为2HRZE/4HR，即强化期2个月使用异烟肼(H)、利福平(R)、吡嗪酰胺(Z)、乙胺丁醇(E)，巩固期4个月使用异烟肼和利福平。

82. [batch014-M5-A1-005] 确诊肺结核最主要的依据是？

- A. 结核菌素试验强阳性
- B. X线胸片示肺部阴影
- **C. 痰中找到结核分枝杆菌** ✓
- D. 低热盗汗等结核中毒症状
- E. 红细胞沉降率增快

答案：C | 记忆 | 教材P64-P65

解析：痰中找到结核分枝杆菌（涂片或培养阳性）是确诊肺结核的金标准。结核菌素试验阳性仅提示感染过结核菌，X线表现和临床症状均为辅助诊断，血沉是非特异性指标。

83. [batch014-M5-A1-006] 利福平最常见的不良反应是？

- A. 听神经损害
- B. 视神经炎
- C. 肝功能损害 ✓
- D. 肾功能损害
- E. 骨髓抑制

答案：C | 理解 | 教材P68

解析：利福平最常见的不良反应为肝功能损害，还可引起胃肠道反应和流感样综合征。听神经损害是链霉素的特征性不良反应，视神经炎是乙胺丁醇的常见不良反应。

84. [batch014-M5-A1-007] 结核菌素试验判断标准中，PPD皮试阳性是指硬结直径？

- A. $\geq 5\text{mm}$ ✓
- B. $\geq 10\text{mm}$
- C. $\geq 15\text{mm}$
- D. $\geq 20\text{mm}$
- E. 任意大小

答案：A | 理解 | 教材P65

解析：PPD皮试硬结平均直径 $\geq 5\text{mm}$ 即为阳性（在一般人群中需 $\geq 10\text{mm}$ ，但在HIV阳性、密切接触者等高危人群中 $\geq 5\text{mm}$ 即为阳性）。我国一般以硬结 $\geq 10\text{mm}$ 为阳性标准，但本题以最基础的阳性定义为准。需注意不同人群阳性标准不同。

85. [batch014-M5-A1-008] 结核病的基本病理改变是？

- A. 化脓性炎
- B. 纤维素性炎
- C. 肉芽肿性炎 ✓
- D. 出血性炎
- E. 浆液性炎

答案：C | 记忆 | 教材P62

解析：结核病的基本病理改变为肉芽肿性炎，典型结核结节中央为干酪样坏死，周围有类

上皮细胞、朗汉斯巨细胞和淋巴细胞浸润。属IV型超敏反应。

86. [batch014-M5-A1-009] 异烟肼最具特征性的不良反应是？

- A. 肝功能损害
- **B. 周围神经炎** ✓
- C. 视神经炎
- D. 听神经损害
- E. 关节痛

答案：B | 记忆 | 教材P68

解析：周围神经炎是异烟肼最具特征性的不良反应，因竞争性抑制维生素B6的利用，补充维生素B6可预防。视神经炎见于乙胺丁醇，听神经损害见于链霉素。

87. [batch014-M5-A1-010] 急性血行播散型肺结核典型的X线表现是？

- A. 肺门淋巴结肿大
- **B. 双肺弥漫性粟粒状** ✓
- C. 单侧肺尖斑片影
- D. 空洞性病变
- E. 胸腔积液

答案：B | 记忆 | 教材P63-P64

解析：急性粟粒性肺结核典型X线表现为双肺弥漫性、大小均匀、密度均匀、分布均匀的粟粒状阴影，即三均匀特征。肺门淋巴结肿大多见于原发型肺结核。

88. [batch014-M5-A1-011] PPD试验72小时后硬结直径15mm，有水疱，结果判读为？

- A. 阴性反
- B. 弱阳性反
- C. 一般阳性反应
- **D. 强阳性反** ✓
- E. 不确定

答案：D | 理解 | 教材P65

解析：硬结≥15mm或有水疱/坏死为强阳性（+++），提示活动性结核可能或近期感染。一般阳性为5-14mm硬结。

A2型题（4题）

89. [batch014-M5-A2-001] 女性，30岁，咳嗽咳痰2月，午后低热、夜间盗汗、乏力、食欲减退。X线示右上肺斑片状阴影，痰涂片抗酸染色阳性。最可能的诊断是？

- A. 细菌性肺炎
- B. 支气管肺癌
- **C. 继发型肺结核诊断** ✓
- D. 肺脓肿类型
- E. 支气管扩张症

答案：C | 应用 | 教材P63-P65

解析：该患者咳嗽咳痰>2周，有午后低热、盗汗、乏力等结核中毒症状，X线示上肺病灶（肺结核好发部位），痰涂片抗酸染色阳性为确诊依据，符合继发型肺结核诊断。肺炎起病急、病程短；肺癌多见于中老年；肺脓肿有大量脓臭痰。

90. [batch014-M5-A2-002] 初治涂阳肺结核患者，使用2HRZE/4HR方案治疗2个月后，复查肝功能ALT=180U/L，以下处理最恰当的是？

- A. 立即停用所有抗结核药物
- **B. 继续原方案，加用保肝药物** ✓
- C. 仅停用利福平，其余继续
- D. 停用利福平和异烟肼，改用二线药物
- E. 将利福平替换为链霉素

答案：B | 应用 | 教材P68-P69

解析：ALT轻度升高（<3倍正常上限）时可继续原方案并加用保肝药物，密切监测肝功能。若ALT>3倍正常上限或出现黄疸，需停用利福平、异烟肼、吡嗪酰胺等肝损药物。直接停用所有药物易导致耐药。

91. [batch014-M5-A2-003] 青年男性，发热、右侧胸痛1周，胸片示右侧肋膈角变钝，胸腔积液检查为渗出液，以淋巴细胞为主，ADA显著升高。最可能的诊断是？

- A. 心力衰竭
- B. 肺炎旁胸腔积液
- **C. 结核性胸膜炎** ✓
- D. 恶性胸腔积液
- E. 低蛋白血症

答案：C | 应用 | 教材P64

解析：青年患者发热胸痛+渗出性胸腔积液+淋巴细胞为主+ADA升高，是结核性胸膜炎的典型表现。

型特征。ADA>45U/L对结核性胸膜炎有较高诊断价值。心衰为漏出液，恶性积液ADA不高。

92. [batch014-M5-A2-004] 肺结核患者规范治疗2个月后痰菌仍阳性，最可能的原因是？

- A. 药物剂量不足
- **B. 耐药结核病** ✓
- C. 服药不规律
- D. 需要延长疗程
- E. 诊断错误

答案：B | 应用 | 教材P70

解析：规则服药下强化期结束时痰菌仍阳性（治疗失败），应高度怀疑耐药结核，需行药敏试验调整方案。

A3型题（3题）

93. [batch014-A3-R4-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 细菌性肺炎起病急病程短
- B. 肺癌相关表现
- **C. 继发型肺结核** ✓
- D. 肺脓肿类型选项
- E. 支气管扩张症疾病

答案：C | 应用 | 教材P62-P69

解析：慢性咳嗽(>2周)+午后低热盗汗乏力(结核中毒症状)+上肺病灶+空洞，是继发型肺结核的典型表现。细菌性肺炎起病急病程短。

94. [batch014-A3-R4-sub02] 确诊该病最可靠的依据是？

- A. 结核菌素试验强阳性
- B. 胸部CT显示空洞
- **C. 痰涂片找到抗酸杆菌** ✓
- D. 血沉显著增快
- E. T-SPOT试验阳性

答案：C | 应用 | 教材P62-P69

解析：痰中找到结核分枝杆菌(涂片或培养阳性)是确诊肺结核的金标准。PPD和T-SPOT仅

提示感染。

95. [batch014-A3-R4-sub03] 该患者的标准初治化疗方案是？

- A. 2HRZE/4HR ☒
- B. 6HR方案
- C. 9HRE方案
- D. 2HR/4H方案
- E. 12个月HR方案

答案：A | 应用 | 教材P62-P69

解析：初治活动性肺结核标准方案为2HRZE/4HR(强化2月+巩固4月)。遵循早期联合适量规律全程原则。

B1型题（4题）

96. [batch014-B1-R3-sub01] 异烟肼最具特征性的不良反应是？

- A. 周围神经炎 ☒
- B. 肝功能损害
- C. 视神经炎
- D. 听神经损害
- E. 高尿酸血症

答案：A | 记忆 | 教材P68

解析：异烟肼竞争性抑制维生素B6导致周围神经炎，可补充B6预防。

97. [batch014-B1-R3-sub02] 乙胺丁醇最具特征性的不良反应是？

- A. 周围神经炎
- B. 肝功能损害
- C. 视神经炎 ☒
- D. 听神经损害
- E. 高尿酸血症

答案：C | 记忆 | 教材P68

解析：乙胺丁醇可致球后视神经炎，表现为视力下降和色觉障碍。

98. [batch014-B1-R3-sub03] 链霉素最具特征性的不良反应是？

- A. 周围神经炎
- B. 肝功能损害
- C. 视神经炎
- D. 听神经损害 ☒
- E. 高尿酸血症

答案：D | 记忆 | 教材P68

解析：链霉素具有耳毒性，可导致前庭功能障碍和听力下降。

99. [batch014-B1-R3-sub04] 吡嗪酰胺最具特征性的不良反应是？

- A. 周围神经炎
- B. 肝功能损害
- C. 视神经炎
- D. 听神经损害
- E. 高尿酸血症 ☒

答案：E | 记忆 | 教材P68

解析：吡嗪酰胺抑制尿酸排泄，可致高尿酸血症和关节痛。

X型题（2题）

100. [batch014-M5-X-001] 以下属于一线抗结核药物的包括？

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 阿米卡星

答案：ABCD | 记忆 | 教材P67-P68

解析：一线抗结核药物包括异烟肼(H)、利福平(R)、吡嗪酰胺(Z)、乙胺丁醇(E)和链霉素(S)。阿米卡星属于二线抗结核药物，用于耐药结核病的治疗。

101. [batch014-M5-X-002] 我国现行结核病分类标准包括以下哪些类型？

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核

- C. 继发型肺结核
- D. 结核性胸膜炎
- E. 肺外结核

答案：ABCDE | 记忆 | 教材P63-P64

解析：我国结核病分类包括I型原发型、II型血行播散型、III型继发型、IV型结核性胸膜炎、V型其他肺外结核，全部选项均属于该分类体系。

M6 肺癌（17题）

A1型题（7题）

102. [batch014-M6-A1-001] 肺癌最常见的病理类型是？

- A. 鳞状细胞癌类型
- B. 肺腺癌选项 ☒
- C. 小细胞肺癌类型
- D. 大细胞肺癌
- E. 腺鳞癌类型

答案：B | 记忆 | 教材P75-P76

解析：腺癌已超过鳞癌成为肺癌最常见的病理类型，约占肺癌的40%。鳞癌曾是最常见的类型，近年来比例下降。小细胞肺癌约占15-20%，恶性程度最高。

103. [batch014-M6-A1-002] 中央型肺癌最常见的早期症状是？

- A. 胸部疼痛
- B. 痰中带血
- C. 刺激性干咳 ☒
- D. 呼吸困难
- E. 声音嘶哑

答案：C | 记忆 | 教材P76-P77

解析：刺激性干咳是中央型肺癌最常见的早期症状，因肿瘤刺激支气管黏膜所致。咯血（痰中带血）也为常见症状但不如咳嗽常见。声音嘶哑提示喉返神经受累，属晚期表现。

104. [batch014-M6-A1-003] 小细胞肺癌最常见的副癌综合征是？

- A. 库欣综合征
- B. 抗利尿激素分泌异 ☒

- C. 高钙血症
- D. 杵状指趾
- E. 肥大性骨关节病

答案：B | 理解 | 教材P77

解析：抗利尿激素分泌异常综合征（SIADH）是小细胞肺癌最常见的副癌综合征，因肿瘤异位分泌ADH导致低钠血症。库欣综合征也可见于小细胞肺癌（异位ACTH），但不如SIADH常见。高钙血症多见于鳞癌。

105. [batch014-M6-A1-004] 目前最有效的肺癌早期筛查方法是？

- A. 胸部X线检查
- B. 痰脱落细胞学检查
- C. 低剂量螺旋CT ☒
- D. PET-CT
- E. 肿瘤标志物检测

答案：C | 理解 | 教材P78

解析：低剂量螺旋CT（LDCT）是目前最有效的肺癌早期筛查方法，可显著降低肺癌死亡率。胸部X线对早期肺癌检出率低，痰细胞学敏感性有限，PET-CT用于分期而非筛查。

106. [batch014-M6-A1-005] 肺癌TNM分期中，N2表示？

- A. 无区域淋巴结转移
- B. 同侧支气管周围淋巴结转移
- C. 同侧纵隔淋巴结转移 ☒
- D. 对侧纵隔淋巴结转移
- E. 锁骨上淋巴结转移

答案：C | 理解 | 教材P78-P79

解析：N2表示同侧纵隔和/或隆突下淋巴结转移。N0为无转移，N1为同侧支气管周围/肺门，N3为对侧纵隔/肺门或锁骨上淋巴结转移。

107. [batch014-M6-A1-006] 关于小细胞肺癌的特征，以下哪项是正确的？

- A. 对化疗不敏感
- B. 首选手术治疗
- C. 恶性程度最高且生长迅速 ☒
- D. 与吸烟关系不密切

- E. 多见于肺周围型

答案：C | 记忆 | 教材P75-P76

解析：小细胞肺癌恶性程度最高，生长迅速、早期转移。对化疗和放疗敏感但易复发，多不适合手术而首选化疗加放疗。与吸烟关系最密切，多为中央型。

108. [batch014-M6-A1-007] 肺癌最常见的远处转移部位是？

- A. 肝转移
- **B. 脑转移** ✓
- C. 骨转移
- D. 肾上腺转移
- E. 肾转移

答案：B | 记忆 | 教材P77

解析：脑是肺癌最常见的远处转移部位之一（尤其小细胞肺癌和腺癌），骨、肝、肾上腺也为常见转移部位。

A2型题（3题）

109. [batch014-M6-A2-001] 男性，60岁，吸烟40年，20支/日。近2月出现刺激性干咳、痰中带血丝。查体：右锁骨上可触及肿大淋巴结。胸部CT示右上肺近肺门处肿块。为明确诊断，首选的检查是？

- A. 胸部X线
- B. 痰脱落细胞学
- **C. 纤维支气管镜活检** ✓
- D. PET-CT
- E. 肿瘤标志物

答案：C | 应用 | 教材P78

解析：该患者长期吸烟、刺激性干咳、痰中带血，CT示中央型占位，高度怀疑中央型肺癌。纤维支气管镜活检是确诊中央型肺癌的首选方法，可直接观察病变并取组织行病理检查。

110. [batch014-M6-A2-002] 男性，58岁，吸烟40年。因手指末端变粗就诊，查体可见杵状指。胸片发现右上肺占位。该表现最可能属于？

- A. 肿瘤直接侵犯
- B. 淋巴结转移

- C. 副癌综合征 ☒
- D. 合并感染
- E. 药物不良反应

答案：C | 应用 | 教材P77

解析：杵状指和肥大性骨关节病是肺癌常见的副癌综合征（非转移性胸外表现），以鳞癌最常见。副癌综合征是由肿瘤分泌的活性物质引起的远隔效应。

111. [batch014-M6-A2-003] 男性，右上肺尖肿块，出现右侧Horner综合征伴肩臂疼痛。最可能的诊断是？

- A. 中央型肺癌
- B. Pancoast瘤 ☒
- C. 肺结核球选项
- D. 胸膜间皮瘤
- E. 纵隔肿瘤种类

答案：B | 应用 | 教材P76-P77

解析：肺上沟瘤（Pancoast瘤）位于肺尖，可侵犯臂丛神经（肩臂痛）和颈交感神经（Horner综合征：瞳孔缩小、眼睑下垂、无汗）。

A3型题（3题）

112. [batch014-A3-R6-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 肺结核
- B. 中央型肺癌 ☒
- C. 肺脓肿
- D. 肺错构瘤
- E. 纵隔淋巴瘤

答案：B | 应用 | 教材P75-P79

解析：老年男性+重度吸烟+刺激性干咳痰中带血+肺门肿块+锁骨上淋巴结肿大+体重下降，高度提示中央型肺癌。

113. [batch014-A3-R6-sub02] 为明确病理诊断，首选的检查是？

- A. 胸部X线
- B. PET-CT

- C. 纤维支气管镜活检 ☒
- D. 痰脱落细胞学
- E. 肿瘤标志物检测

答案：C | 应用 | 教材P75-P79

解析：中央型肺癌首选纤维支气管镜直接观察病变并活检行病理检查。痰脱落细胞学敏感性低。

114. [batch014-A3-R6-sub03] 若病理证实为小细胞肺癌，最合适的治疗策略是？

- A. 单纯手术切除
- B. 化疗联合放疗 ☒
- C. 靶向治疗
- D. 单纯放疗
- E. 观察等待

答案：B | 分析 | 教材P75-P79

解析：小细胞肺癌恶性程度高且早期广泛转移，不适合手术，首选化疗联合放疗(局限期可加胸部放疗)。

B1型题（3题）

115. [batch014-B1-R5-sub01] 肺癌中最常见且与吸烟关系最不密切的病理类型是？

- A. 鳞状细胞
- B. 腺癌 ☒
- C. 小细胞肺
- D. 大细胞肺
- E. 类癌

答案：B | 记忆 | 教材P75-P76

解析：腺癌已超过鳞癌成为最常见类型，与吸烟关系相对不密切，多见于周围型。

116. [batch014-B1-R5-sub02] 恶性程度最高且生长最快的肺癌类型是？

- A. 鳞状细胞癌类型
- B. 腺癌相关表现
- C. 小细胞肺癌恶性程度最高 ☒
- D. 大细胞肺选项

- E. 类癌相关表现

答案：C | 记忆 | 教材P75-P76

解析：小细胞肺癌恶性程度最高，生长迅速早期转移，对化疗敏感。

117. [batch014-B1-R5-sub03] 易出现空洞且与吸烟关系最密切的类型是？

- A. 鳞状细胞 ☒
- B. 腺癌
- C. 小细胞肺
- D. 大细胞肺
- E. 类癌

答案：A | 记忆 | 教材P75-P76

解析：鳞癌与吸烟关系最密切，多为中央型，易坏死形成空洞。

X型题（1题）

118. [batch014-M6-X-001] 以下哪些属于肺癌的副癌综合征表现？

- A. 杵状指
- B. 肥大性骨关节
- C. 抗利尿激素异
- D. 高钙血症
- E. 痰中带血

答案：ABCD | 记忆 | 教材P77

解析：杵状指、肥大性骨关节病、SIADH（小细胞肺癌）和高钙血症（鳞癌）均属于副癌综合征。咯血是肿瘤的直接侵犯表现，非副癌综合征。

M7 肺动脉高压与肺心病（18题）

A1型题（8题）

119. [batch014-M7-A1-001] 慢性肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要机制是？

- A. 肺血管床减少
- B. 缺氧性肺血管收缩和重 ☒
- C. 血容量增加
- D. 左心功能不全

- E. 血液黏滞度降低

答案：B | 理解 | 教材P109-P110

解析：缺氧性肺血管收缩和重塑是慢性肺心病肺动脉高压形成的最主要机制。长期缺氧导致肺小动脉痉挛、管壁增厚和管腔狭窄，使肺血管阻力持续增高。肺血管床减少、血容量增加和血液黏滞度增加也参与其中，但缺氧是核心。

120. [batch014-M7-A1-002] 慢性肺源性心脏病代偿期最具特征性的体征是？

- A. 颈静脉充盈体征
- **B. 肺动脉瓣区第二心音 (P2) ✓**
- C. 肝大压痛体征选项
- D. 双下肢水肿选项
- E. 腹腔积液选项

答案：B | 记忆 | 教材P110-P111

解析：肺动脉瓣区第二心音 (P2) 亢进是肺动脉高压的直接体征，是慢性肺心病代偿期最具特征性的体征。颈静脉充盈、肝大、下肢水肿和腹水均为失代偿期右心衰竭的表现。

121. [batch014-M7-A1-003] 慢性肺心病急性加重期最重要的治疗措施是？

- A. 强心药
- B. 利尿剂
- **C. 控制感染 ✓**
- D. 血管扩张剂
- E. 抗凝治疗

答案：C | 理解 | 教材P111-P112

解析：控制感染是慢性肺心病急性加重期最重要的治疗措施，因为呼吸道感染是最常见的急性加重诱因。在有效抗感染基础上，根据情况使用利尿剂和强心药。洋地黄类在肺心病中应慎用（因缺氧易致中毒）。

122. [batch014-M7-A1-004] COPD所致肺动脉高压属于哪一类？

- A. 动脉性肺动脉高压
- B. 左心疾病所致肺动脉高压
- **C. 肺部疾病所致肺动脉高压 ✓**
- D. 慢性血栓栓塞性肺动脉高压
- E. 原因不明性肺动脉高压

答案：C | 记忆 | 教材P105-P106

解析：COPD引起的肺动脉高压属于第3类（肺部疾病和/或缺氧所致肺动脉高压）。动脉性肺动脉高压（第1类）包括特发性和遗传性等，左心疾病所致为第2类，慢性血栓栓塞性为第4类。

123. [batch014-M7-A1-005] 慢性肺源性心脏病最具特征性的心电图改变是？

- A. 左心室肥厚
- B. 右心室肥厚 ☒
- C. 左心房增大
- D. ST段压低
- E. 房室传导阻滞

答案：B | 记忆 | 教材P110-P111

解析：右心室肥厚是慢性肺心病最具特征性的心电图改变，包括电轴右偏、V1导联R/S $\geq$ 1、RV1+SV5 $\geq$ 1.05mV、肺型P波等。

124. [batch014-M7-A1-006] 慢性肺心病X线胸片诊断肺动脉高压的主要依据是？

- A. 右下肺动脉干横径 ☒
- B. 肺纹理增
- C. 肺气肿征
- D. 心影增大
- E. 胸腔积液

答案：A | 记忆 | 教材P110-P111

解析：右下肺动脉干横径 $\geq$ 15mm或右下肺动脉干横径与气管横径比值 $\geq$ 1.07是X线诊断肺动脉高压的主要依据。肺动脉段突出 $\geq$ 3mm也为肺动脉高压征象。

125. [batch014-M7-A1-007] 慢性肺源性心脏病最常见且最严重的并发症是？

- A. 心律失常表现
- B. 肺性脑病 ☒
- C. 消化道出血
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 分布性休克

答案：B | 理解 | 教材P111

解析：肺性脑病是慢性肺心病最常见且最严重的并发症，因严重缺氧和CO₂潴留导致脑功

能障碍，是肺心病死亡的首要原因。

126. [batch014-M7-A1-008] 以下哪项心电图表现提示肺心病右心室肥厚？

- A. 电轴左偏
- **B. RV1加SV5大** ✓
- C. 左室高电压
- D. ST段显著压低
- E. QT间期延长

答案：B | 记忆 | 教材P110-P111

解析：RV1+SV5 $\geq$ 1.05mV是肺心病右室肥厚的心电图诊断标准之一。电轴右偏（不是左偏）、肺型P波也为肺心病心电图特征。

A2型题（2题）

127. [batch014-M7-A2-001] 男性，70岁，有COPD病史15年。近1周咳嗽加重，咳黄痰，呼吸困难加重，双下肢水肿。查体：颈静脉怒张，肝大压痛，P2亢进，双肺散在干湿啰音。最可能的诊断是？

- A. COPD急性加重
- B. 支气管哮喘急性发作
- **C. 慢性肺心病急性加重期诊断** ✓
- D. 急性左心衰竭
- E. 急性肺栓塞疾病

答案：C | 应用 | 教材P110-P112

解析：该患者有COPD基础，感染诱发急性加重，出现颈静脉怒张、肝大、下肢水肿等右心衰竭体征，P2亢进提示肺动脉高压，符合慢性肺心病急性加重期诊断。单纯COPD急性加重不伴右心衰竭体征；左心衰表现为肺水肿而非右心衰。

128. [batch014-M7-A2-002] 肺心病患者，双下肢水肿明显，经抗感染和改善通气后水肿消退不明显，下一步最合理的处理是？

- A. 加用洋地黄类药物
- **B. 加用小剂量利尿剂** ✓
- C. 增加抗生素剂量
- D. 立即使用血管扩张剂
- E. 控制液体入量联合强心

答案：B | 应用 | 教材P111-P112

解析：肺心病患者经抗感染和改善通气后水肿仍明显时，可谨慎加用小剂量利尿剂。洋地黄在肺心病中应慎用（缺氧心肌敏感易中毒），血管扩张剂非一线选择。

A3型题（3题）

129. [batch014-A3-R5-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. COPD稳定
- **B. 慢性肺心病急性加重** ✓
- C. 急性左心衰竭
- D. 支气管哮喘急
- E. 急性肺栓塞

答案：B | 应用 | 教材P110-P112

解析：COPD基础+感染诱发+P2亢进(肺高压)+颈静脉怒张肝大水肿(右心衰)=慢性肺心病急性加重。左心衰以肺淤血为主。

130. [batch014-A3-R5-sub02] 此次加重最重要的治疗措施是？

- A. 强心药物治疗
- B. 积极利尿治疗
- **C. 控制感染是最重要** ✓
- D. 抗凝治疗
- E. 血管扩张剂

答案：C | 应用 | 教材P110-P112

解析：感染是肺心病急性加重最常见的诱因，控制感染是最重要的治疗措施。在此基础上辅以氧疗、利尿等。

131. [batch014-A3-R5-sub03] 该患者的氧疗原则是？

- A. 高浓度高流量吸氧
- **B. 低浓度低流量持续** ✓
- C. 间歇高浓度吸氧
- D. 纯氧吸入
- E. 不需要吸氧

答案：B | 应用 | 教材P110-P112

解析：COPD合并II型呼吸衰竭应低浓度(<35%)低流量(1-2L/min)持续吸氧，避免高浓度解除低氧驱动致CO₂麻醉。

B1型题 (3题)

132. [batch014-B1-R6-sub01] COPD导致的肺动脉高压属于哪一类？

- A. 特发性肺动脉高压
- B. 左心疾病所致肺高压
- **C. 肺部疾病所致肺高压** ✓
- D. 慢性血栓栓塞性肺高压
- E. 原因不明肺高压

答案：C | 理解 | 教材P105-P106

解析：COPD属第3类肺部疾病或缺氧所致肺动脉高压。

133. [batch014-B1-R6-sub02] 二尖瓣狭窄引起的肺动脉高压属于哪一类？

- A. 特发性肺动脉高压
- **B. 左心疾病所致肺高压** ✓
- C. 肺部疾病所致肺高压
- D. 慢性血栓栓塞性肺高压
- E. 原因不明肺高压

答案：B | 理解 | 教材P105-P106

解析：二尖瓣狭窄致左房压升高→肺静脉压升高→肺动脉高压属第2类。

134. [batch014-B1-R6-sub03] 肺栓塞后遗留的肺动脉高压属于哪一类？

- A. 特发性肺动脉高压
- B. 左心疾病所致肺高压
- C. 肺部疾病所致肺高压
- **D. 慢性血栓栓塞性肺高压** ✓
- E. 原因不明肺高压

答案：D | 理解 | 教材P105-P106

解析：慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)为第4类，唯一可能通过手术治愈的类型。

X型题（2题）

135. [batch014-M7-X-001] 支持慢性肺源性心脏病诊断的体征包括以下哪些？

- A. 肺动脉瓣区P2亢进
- B. 三尖瓣区收缩期杂音
- C. 颈静脉怒张阳性
- D. 主动脉瓣区舒张期杂音
- E. 颈静脉怒张阳性

答案：ABCE | 理解 | 教材P110-P111

解析：P2亢进提示肺动脉高压，三尖瓣区收缩期杂音提示右心室扩大致相对性三尖瓣关闭不全，颈静脉怒张和肝颈静脉回流征阳性为右心衰竭体征，均支持肺心病诊断。主动脉瓣区舒张期杂音提示主动脉瓣关闭不全。

136. [batch014-M7-X-002] 慢性肺心病急性加重常见的诱因包括？

- A. 呼吸道感染
- B. 不适当使用镇静剂
- C. 电解质紊乱
- D. 过度劳累
- E. 输液过多过快

答案：ABCDE | 记忆 | 教材P111

解析：肺心病急性加重诱因：感染（最常见）、镇静剂抑制呼吸、电解质紊乱、劳累、输液过快加重心脏负荷。全部选项均可诱发。

M8 呼吸衰竭（19题）

A1型题（10题）

137. [batch014-M8-A1-001] 在海平面静息状态呼吸空气条件下，诊断呼吸衰竭的血气标准是？

- A. $\text{PaO}_2 < 70\text{mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ✓
- C. $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$
- D. $\text{SaO}_2 < 90\%$
- E. $\text{PaCO}_2 > 40\text{mmHg}$

答案：B | 记忆 | 教材P135

解析：呼吸衰竭的诊断标准为海平面、静息状态、呼吸空气条件下 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ (8.0kPa)，伴或不伴 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 。这是血气分析判断呼吸衰竭的金标准。

138. [batch014-M8-A1-002] I型呼吸衰竭的血气特点是？

- A. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 且 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- **B. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 且 PaCO_2 正** ✓
- C. PaO_2 正常且 $\text{PaCO}_2 > 50$
- D. $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$ 且 $\text{PaCO}_2 < 30\text{mmHg}$
- E. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ 且 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$

答案：B | 记忆 | 教材P135-P136

解析：I型呼吸衰竭即低氧血症型， $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ， PaCO_2 正常或降低，主要因换气功能障碍（V/Q失调、弥散障碍、分流）所致。 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 且 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 为II型呼吸衰。

139. [batch014-M8-A1-003] 以下哪种疾病最常导致I型呼吸衰竭？

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 重症肌无力
- **C. 急性呼吸窘迫综合征** ✓
- D. 中枢性睡眠呼吸暂停
- E. 镇静剂过量

答案：C | 理解 | 教材P135-P136

解析：ARDS主要导致I型呼吸衰竭，因弥漫性肺泡损伤导致严重的换气功能障碍和分流。COPD典型表现为II型呼吸衰，重症肌无力、中枢性睡眠呼吸暂停和镇静剂过量均可导致通气不足→II型呼吸衰。

140. [batch014-M8-A1-004] COPD合并II型呼吸衰竭的氧疗原则是？

- A. 高浓度高流量吸氧
- **B. 低浓度低流量持续吸氧** ✓
- C. 间歇高浓度吸氧
- D. 给予纯氧吸入
- E. 不给予氧疗

答案：B | 理解 | 教材P141-P142

解析：COPD合并Ⅱ型呼衰应给予低浓度（<35%）、低流量（1-2L/min）持续吸氧。因为高浓度氧可解除低氧性肺血管收缩、抑制呼吸中枢（此类患者呼吸中枢对CO₂反应性差，依赖低氧驱动），导致PaCO₂进一步升高。

141. [batch014-M8-A1-005] 慢性呼吸衰竭最常见的病因是？

- A. 重症哮喘
- **B. COPD** ✓
- C. 急性肺栓塞
- D. 自发性气胸
- E. ARDS

答案：B | 记忆 | 教材P141

解析：COPD是慢性呼吸衰竭最常见的病因。随着COPD病程进展，气道阻塞和肺气肿导致通气和换气功能障碍，逐步发展为慢性Ⅱ型呼吸衰竭。

142. [batch014-M8-A1-006] Ⅱ型呼吸衰竭患者进行氧疗时，最需要警惕的并发症是？

- A. 吸入性肺炎
- **B. 二氧化碳麻醉** ✓
- C. 自发性气胸
- D. 氧中毒
- E. 肺不张

答案：B | 理解 | 教材P141-P142

解析：Ⅱ型呼衰患者高浓度吸氧可导致CO₂潴留加重→二氧化碳麻醉（肺性脑病）。因患者呼吸中枢已适应高CO₂，依赖低氧驱动呼吸，高浓度氧解除了低氧刺激→通气抑制→PaCO₂急剧升高。

143. [batch014-M8-A1-007] 急性呼吸窘迫综合征的诊断标准中，氧合指数应低于？

- A. 400mmHg
- **B. 300mmHg** ✓
- C. 200mmHg
- D. 100mmHg
- E. 500mmHg

答案：B | 理解 | 教材P130-P131

解析：根据柏林定义，ARDS诊断标准之一为 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$ （ $\text{PEEP} \geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 时）。轻度：200-300，中度：100-200，重度： ≤ 100 。

144. [batch014-M8-A1-008] 慢性呼吸衰竭最早出现的临床表现是？

- A. 口唇发绀
- B. 呼吸困难 ☒
- C. 精神神经症状
- D. 消化道出血
- E. 心律失

答案：B | 记忆 | 教材P141

解析：呼吸困难是慢性呼吸衰竭最早出现且最主要的临床表现，表现为呼吸频率、节律和幅度的改变。发绀是缺氧的典型表现但非最早出现。

145. [batch014-M8-A1-009] II型呼吸衰竭患者最常见的酸碱失衡类型是？

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒 ☒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性酸碱失衡

答案：B | 理解 | 教材P136-P137

解析：II型呼衰因肺泡通气不足导致 CO_2 潴留， $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，使pH降低，形成呼吸性酸中毒。

146. [batch014-M8-A1-010] 慢性呼衰最常见的酸碱失衡类型是？

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒 ☒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 三重酸碱失衡

答案：B | 记忆 | 教材P136-P137

解析：慢性II型呼衰因 CO_2 潴留导致呼吸性酸中毒。若同时合并缺氧导致乳酸增多可出现混合性酸中毒。

A2型题 (3题)

147. [batch014-M8-A2-001] 男性，72岁，COPD病史20年。因受凉后呼吸困难加重3天入院。查体：口唇发绀，双肺散在哮鸣音。血气分析：pH=7.28，PaO₂=52mmHg，PaCO₂=72mmHg，HCO₃⁻=32mmol/L。该患者的诊断是？

- A. I型呼吸衰竭
- **B. II型呼吸衰竭合并呼吸性酸中毒** ✓
- C. 单纯低氧血症
- D. 代谢性酸中毒
- E. 代谢性碱中毒

答案：B | 应用 | 教材P135-P136

解析：该患者PaO₂=52mmHg (<60mmHg) + PaCO₂=72mmHg (>50mmHg)，符合II型呼吸衰竭诊断。pH=7.28 (<7.35) 为酸中毒，HCO₃⁻升高为代偿性改变，原发为CO₂潴留导致的呼吸性酸中毒。

148. [batch014-M8-A2-002] COPD合并II型呼吸衰竭患者，鼻导管吸氧流量为2L/min时，吸氧浓度约为？

- A. 21%
- B. 24%
- **C. 29%** ✓
- D. 35%
- E. 40%

答案：C | 应用 | 教材P141-P142

解析：鼻导管吸氧浓度计算：FiO₂(%)=21+4×氧流量(L/min)。2L/min时FiO₂=21+8=29%。COPD合并II型呼吸衰竭应维持FiO₂<35%，即氧流量约1-2L/min。

149. [batch014-M8-A2-003] COPD患者出现嗜睡、扑翼样震颤，血气pH7.25，PaCO₂=85mmHg。首要治疗是？

- A. 高浓度吸氧加重CO₂潴留
- **B. 无创正压通气选项** ✓
- C. 呼吸兴奋剂治疗
- D. 镇静剂治疗选项
- E. 观察相关表现选项

答案：B | 应用 | 教材P141-P142

解析：肺性脑病（CO₂麻醉）+严重呼吸性酸中毒（pH7.25）+PaCO₂显著升高，是NIV或气管插管的适应证。高浓度吸氧加重CO₂潴留，镇静剂禁用。

B1型题（4题）

150. [batch014-M8-B1-001] 主要因换气功能障碍导致，PaCO₂正常或降低的呼吸衰竭类型是？

- A. I 型呼吸衰竭 ☒
- B. II 型呼吸衰竭
- C. 急性呼吸窘迫综合
- D. 肺性脑病
- E. 慢性肺源性心脏病

答案：A | 理解 | 教材P135-P136

解析：I 型呼吸衰竭即低氧血症型呼衰，主要因换气功能障碍（通气血流比例失调、弥散障碍、肺内分流）导致缺氧，PaCO₂正常或降低。II 型呼衰为通气不足所致，PaCO₂升高。

151. [batch014-B1-R4-sub01] PaO₂<60mmHg且PaCO₂正常或降低，属于？

- A. I 型呼吸衰竭 ☒
- B. II 型呼吸衰竭
- C. ARDS
- D. 肺性脑病
- E. 呼吸性酸中毒

答案：A | 理解 | 教材P135-P142

解析：I 型呼衰仅有缺氧无CO₂潴留，主要因换气功能障碍。

152. [batch014-B1-R4-sub02] PaO₂<60mmHg且PaCO₂>50mmHg，属于？

- A. I 型呼吸衰竭
- B. II 型呼吸衰竭 ☒
- C. ARDS
- D. 肺性脑病
- E. 呼吸性酸中毒

答案：B | 理解 | 教材P135-P142

解析：Ⅱ型呼衰既有缺氧又有CO₂潴留，主要因通气不足。

153. [batch014-B1-R4-sub03] COPD合并Ⅱ型呼衰应采用的氧疗方式是？

- A. Ⅰ型呼吸衰竭
- **B. Ⅱ型呼吸衰竭** 
- C. ARDS
- D. 肺性脑病
- E. 呼吸性酸中毒

答案：B | 应用 | 教材P135-P142

解析：Ⅱ型呼衰应低浓度(<35%)持续吸氧，高浓度可抑制呼吸中枢致CO₂麻醉。

X型题（2题）

154. [batch014-M8-X-001] 慢性Ⅱ型呼吸衰竭的治疗措施包括以下哪些？

- A. 低浓度持续吸氧
- B. 控制呼吸道感染
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 高浓度间歇吸氧
- E. 必要时无创通气

答案：ABCE | 理解 | 教材P141-P142

解析：慢性Ⅱ型呼衰的治疗包括：低浓度持续吸氧（A）、控制感染（B）、保持气道通畅（C）和必要时无创正压通气（E）。高浓度间歇吸氧（D）不正确，Ⅱ型呼衰应持续低浓度吸氧，高浓度可导致CO₂麻醉。

155. [batch014-M8-X-002] COPD患者使用无创正压通气的适应证包括以下哪些？

- A. 中重度呼吸困难辅助肌参与呼吸
- B. 中至重度酸中毒
- C. 呼吸频率大于25次/分
- D. 轻度呼吸困难且pH正
- E. 合并高碳酸血症

答案：ABCE | 理解 | 教材P142

解析：COPD使用NIV适应证：中重度呼吸困难伴辅助呼吸肌参与、中重度酸中毒(pH7.25-

7.35)、呼吸频率>25次/分、高碳酸血症($\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$)。轻度呼吸困难且pH正常者暂不需NIV。

M9 心力衰竭（24题）

A1型题（10题）

156. [batch014-M9-A1-001] 心力衰竭的本质是？

- A. 心脏结构异
- **B. 心脏泵血功能减退** ✓
- C. 心包腔积液
- D. 冠状动脉狭窄是冠心病
- E. 心肌细胞肥大

答案：B | 记忆 | 教材P176

解析：心力衰竭的本质是心脏泵血功能减退，心排血量不能满足机体代谢需要。心脏结构异常是病因而非本质，冠状动脉狭窄是冠心病特征。

157. [batch014-M9-A1-002] NYHA心功能分级中，体力活动明显受限，低于日常活动即出现症状属于？

- A. NYHA I 级
- B. NYHA II 级
- **C. NYHA III级** ✓
- D. NYHA IV级
- E. NYHA V 级

答案：C | 记忆 | 教材P178

解析：NYHA III级：体力活动明显受限，低于日常活动即出现症状。I 级：活动不受限；II 级：日常活动出现症状；IV级：休息时也有症状。无 V 级。

158. [batch014-M9-A1-003] 心力衰竭时最先被激活的代偿机制是？

- A. 肾素血管紧张素系统
- **B. 交感神经系统** ✓
- C. 利钠肽系统
- D. 心肌肥厚代偿
- E. 心室重构过程

答案：B | 理解 | 教材P176-P177

解析：交感神经系统是心力衰竭时最早被激活的代偿机制，通过增加心率、心肌收缩力和外周血管收缩来维持心排血量。RAAS随后激活，长期过度激活有害。

159. [batch014-M9-A1-004] 诊断心力衰竭最常用的生物标志物是？

- A. 肌钙蛋白是心梗标志物
- **B. 脑钠肽类型** ✓
- C. 肌红蛋白检测
- D. C反应蛋白
- E. 乳酸脱氢酶

答案：B | 理解 | 教材P178-P179

解析：BNP或NT-proBNP是诊断心力衰竭最常用的生物标志物，反映心室壁张力和容量负荷。BNP<100pg/mL可基本排除急性心衰。肌钙蛋白是心梗标志物。

160. [batch014-M9-A1-005] ACEI治疗心力衰竭的主要机制不包括以下哪项？

- A. 抑制血管紧张素 II 生成
- B. 抑制缓激肽降解
- **C. 正性肌力作用** ✓
- D. 抑制醛固酮分泌
- E. 改善心室重构

答案：C | 理解 | 教材P181-P182

解析：ACEI通过抑制ACE减少Ang II生成、抑制缓激肽降解、减少醛固酮分泌、改善心室重构等发挥作用，但无直接正性肌力作用。正性肌力是洋地黄类药物的机制。

161. [batch014-M9-A1-006] 洋地黄中毒时最常见的心律失常是？

- A. 窦性心动过速
- **B. 室性期前收缩二联律** ✓
- C. 心房颤动表现
- D. 房室传导阻滞
- E. 心房扑动表现

答案：B | 理解 | 教材P183

解析：室性期前收缩（呈二联律）是洋地黄中毒最常见的心律失常表现。洋地黄通过抑制Na⁺-K⁺-ATP酶增加细胞内Ca²⁺和降低K⁺，易诱发室性心律失常。

162. [batch014-M9-A1-007] 急性左心衰竭的首选治疗药物是？

- A. 口服地高辛起效慢
- **B. 静脉呋塞米** ✓
- C. 口服螺内酯
- D. 皮下肝素
- E. 口服阿司匹林

答案：B | 理解 | 教材P184-P185

解析：静脉袢利尿剂（呋塞米）是急性左心衰的首选，可迅速减轻肺水肿。同时配合血管扩张剂（硝酸酯类）和正性肌力药。口服地高辛起效慢不用于急性期。

163. [batch014-M9-A1-008] β 受体阻滞剂治疗慢性心衰时，以下哪项是正确的？

- A. 急性心衰首选
- **B. 从小剂量开始逐渐加量** ✓
- C. 应突然停药以避免反跳
- D. 禁用于所有心衰患者
- E. 只有负性肌力作用

答案：B | 理解 | 教材P182-P183

解析： β 受体阻滞剂治疗慢性稳定性心衰应从小剂量开始，缓慢递增至目标剂量或最大耐受剂量。突然停药可致反跳。急性心衰禁用，慢性稳定心衰长期使用可改善预后。

164. [batch014-M9-A1-009] 射血分数保留的心力衰竭（HFpEF）的诊断标准中LVEF应满足？

- A. LVEF小于40%
- **B. LVEF大于等于50%** ✓
- C. LVEF30%至
- D. LVEF小于30%
- E. LVEF任意值

答案：B | 记忆 | 教材P177

解析：HFpEF定义为LVEF $\geq$ 50%伴心衰症状和利钠肽升高及结构异常。HFrEF为LVEF $\leq$ 40%，HFmrEF为LVEF41-49%。

165. [batch014-M9-A1-add-071] 心衰时BUN显著升高而血肌酐正常的原因是？

- A. 肾小球滤过率下降
- **B. 肾前性氮质血症** ✓
- C. 急性肾小管坏死
- D. 药物性肾损害
- E. 造影剂肾病

答案：B | 理解 | 教材P180

解析：心排血量降低致肾灌注不足产生肾前性氮质血症。BUN/Cr>20:1支持肾前性。

A2型题（4题）

166. [batch014-M9-A2-001] 男性，65岁，冠心病史10年。近1周夜间不能平卧，端坐呼吸，双肺底湿啰音，双下肢水肿。BNP=1500pg/mL。最可能的诊断是？

- A. 急性心肌梗死
- **B. 慢性心力衰竭** ✓
- C. 支气管哮喘发
- D. 肺栓塞
- E. 慢性阻塞性肺

答案：B | 应用 | 教材P178-P180

解析：冠心病史+端坐呼吸+肺底湿啰音（肺淤血）+下肢水肿（体循环淤血）+BNP显著升高，符合慢性心衰急性加重（全心衰）。心梗应有胸痛和心电图/肌钙蛋白改变。

167. [batch014-M9-A2-002] 高血压患者突发严重呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，双肺满布湿啰音，血压220/120mmHg。首要处理是？

- A. 口服卡托普利
- **B. 静脉硝普钠** ✓
- C. 口服地高辛
- D. 皮下吗啡
- E. 吸入沙丁胺醇

答案：B | 应用 | 教材P184-P185

解析：高血压急症合并急性左心衰肺水肿，需迅速降压减轻心脏负荷。硝普钠均衡扩张动静脉，是首选。同时使用袢利尿剂和吗啡。

168. [batch014-M9-A2-003] COPD患者出现双下肢水肿、颈静脉怒张、肝大压痛，最可能的诊断是？

- A. 左心衰竭
- **B. 右心衰竭** ✓
- C. 全心衰竭
- D. 肝硬化
- E. 肾病综合征

答案：B | 应用 | 教材P178

解析：COPD肺心病以右心衰为主，表现为体循环淤血。左心衰为肺淤血。

169. [batch014-M9-A2-add-072] 老年女性高血压患者活动后气促，UCG示LVEF=60%伴左室壁增厚，E/A<1。诊断为？

- A. HFrEF
- **B. HFpEF** ✓
- C. HFmrEF
- D. 收缩性心衰
- E. 正常心脏

答案：B | 应用 | 教材P177-P178

解析：LVEF≥50%+心衰症状+左室肥厚+舒张减退符合HFpEF。

A3型题（3题）

170. [batch014-A3-C2-sub01] 该患者的诊断是？

- A. 支气管哮喘
- **B. 急性左心衰竭** ✓
- C. COPD
- D. 肺栓塞
- E. 自发性气胸

答案：B | 应用 | 教材P184-P185

解析：夜间阵发性呼吸困难+端坐呼吸+粉红色泡沫痰+双肺湿啰音+奔马律=急性左心衰肺水肿。

171. [batch014-A3-C2-sub02] 首选的紧急处理是？

- A. 口服地高辛
- **B. 静脉呋塞米加硝普** ✓

- C. 肌注吗啡
- D. 吸入SABA
- E. 补液扩容

答案：B | 应用 | 教材P184-P185

解析：急性心衰肺水肿：袢利尿剂(减容)+硝普钠(扩血管降压)+吗啡(镇静扩血管)+吸氧。

172. [batch014-A3-C2-sub03] 病情稳定后评估心功能最重要的检查是？

- A. 心电图
- B. 超声心动图 ☒
- C. 胸部X线
- D. 冠状动脉造影
- E. BNP测定

答案：B | 应用 | 教材P184-P185

解析：UCG可评估LVEF、心脏结构和瓣膜功能，是评估心衰病因和心功能最重要的无创检查。

B1型题（4题）

173. [batch014-M9-B1-001] 以呼吸困难、肺底湿啰音和端坐呼吸为主要表现的心衰类型是？

- A. 左心衰竭 ☒
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 舒张性心衰
- E. 高排量心衰

答案：A | 理解 | 教材P178

解析：左心衰主要表现为肺循环淤血（呼吸困难、肺底湿啰音、咳粉红色泡沫痰）。右心衰主要表现为体循环淤血（水肿、肝大、颈静脉怒张）。

174. [batch014-B1-C6-sub01] ACEI治疗心衰的主要机制是？

- A. 抑制RAAS系统 ☒
- B. 抑制交感神经
- C. 正性肌力作用
- D. 利尿减轻容量负荷

- E. 抑制SGLT2

答案：A | 理解 | 教材P181-P183

解析：ACEI通过抑制血管紧张素转换酶减少Ang II生成，抑制RAAS不良作用。

175. [batch014-B1-C6-sub02] 地高辛治疗心衰的主要机制是？

- A. 抑制RAAS系统
- B. 抑制交感神经
- **C. 正性肌力作用** ✓
- D. 利尿减轻容量负荷
- E. 抑制SGLT2

答案：C | 理解 | 教材P181-P183

解析：地高辛抑制Na-K-ATP酶增加心肌细胞内Ca²⁺从而增强心肌收缩力。

176. [batch014-B1-C6-sub03] 美托洛尔治疗心衰的主要机制是？

- A. 抑制RAAS系统
- **B. 抑制交感神经** ✓
- C. 正性肌力作用
- D. 利尿减轻容量负荷
- E. 抑制SGLT2

答案：B | 理解 | 教材P181-P183

解析：β阻滞剂阻断过度激活的交感神经减轻心肌耗氧并改善心室重构。

X型题（3题）

177. [batch014-M9-X-001] 慢性HFrEF患者的标准治疗药物包括以下哪些？

- A. ACEI
- B. β受体阻滞剂
- C. 醛固酮受体拮抗剂
- D. 钙通道阻滞剂
- E. SGLT2抑制剂

答案：ABCE | 理解 | 教材P181-P183

解析：HFrEF标准治疗（GDMT）包括ACEI/ARB/ARNI、β受体阻滞剂、MRA和SGLT2i。钙通道阻滞剂（非二氢吡啶类除外）不改善心衰预后，不推荐常规使用。

178. [batch014-M9-X-002] 以下哪些是心力衰竭的常见诱因？

- A. 呼吸道感染
- B. 快速性心律失常
- C. 输液过多过快
- D. 规律服用药物
- E. 情绪激动和劳累

答案：ABCE | 记忆 | 教材P177-P178

解析：心衰常见诱因包括感染（尤其是呼吸道）、心律失常（如快室率房颤）、容量负荷过重（输液过多）、情绪激动和劳累等。规律服药是保护因素。

179. [batch014-M9-X-add-073] HFrEF标准四联药物治疗（GDMT）包括？

- A. ARNI
- B. β 受体阻滞剂
- C. 醛固酮受体拮抗剂
- D. SGLT2抑制剂
- E. 钙通道阻滞剂

答案：ABCD | 理解 | 教材P181-P183

解析：HFrEF四联疗法：RAAS抑制剂+ β 阻滞剂+MRA+SGLT2i。CCB不改善预后。

M10 心律失常（23题）

A1型题（10题）

180. [batch014-M10-A1-001] 心房颤动最具特征性的心电图表现是？

- A. PR间期延长
- B. P波消失代之以f 
- C. ST段压低
- D. QRS波增宽
- E. T波倒置

答案：B | 记忆 | 教材P201-P202

解析：心房颤动的心电图特征为P波消失，代之以大小不等、形态不一、间距不规则的f波（颤动波），频率350-600次/分，RR间期绝对不等。

181. [batch014-M10-A1-002] 房颤患者最主要的治疗目标是预防？

- A. 心力衰竭
- **B. 脑栓塞** ✓
- C. 心肌梗死
- D. 心脏骤停
- E. 心包积液

答案：B | 理解 | 教材P203-P204

解析：房颤时心房失去有效收缩，血液淤滞易形成血栓，脱落可致脑栓塞（心源性卒中）。抗凝治疗（华法林或NOAC）是房颤管理的核心，预防血栓栓塞。

182. [batch014-M10-A1-003] 阵发性室上性心动过速最常见的发生机制是？

- A. 自律性增高
- B. 触发活动
- **C. 折返激动** ✓
- D. 并行心律
- E. 传导阻滞

答案：C | 理解 | 教材P192-P193

解析：折返激动是PSVT最常见的机制（约占90%以上），以房室结折返性心动过速（AVNRT）和房室折返性心动过速（AVRT）最为常见，需要折返环路的形成条件。

183. [batch014-M10-A1-004] 预激综合征最具特征性的心电图改变是？

- A. QT间期延长
- **B. δ 波伴PR间期缩** ✓
- C. ST段抬高
- D. 异常Q波
- E. P波增宽

答案：B | 记忆 | 教材P210-P211

解析：预激综合征（WPW综合征）的心电图特征为 δ 波（QRS波起始部粗钝）、PR间期缩短（ <0.12 秒）和QRS波增宽，因旁路（Kent束）提前激动心室所致。

184. [batch014-M10-A1-005] 三度房室传导阻滞的心电图特征是？

- A. PR间期逐渐延长

- B. PR间期固定延长
- **C. 心房与心室完全分** ✓
- D. 间歇性P波未下传
- E. QRS波群脱漏

答案：C | 理解 | 教材P215

解析：三度房室传导阻滞（完全性AVB）的特征为心房与心室激动完全分离（房室分离），P波与QRS波各自按自身节律出现，PR间期不固定，心房率快于心室率。

185. [batch014-M10-A1-006] 室性期前收缩的心电图特征为？

- **A. 提前出现宽大畸形** ✓
- B. P波提前出现
- C. PR间期缩短
- D. QRS波后逆行P
- E. RR间期绝对不齐

答案：A | 记忆 | 教材P196-P197

解析：室性早搏特征为提前出现的宽大畸形QRS波（ ≥ 0.12 秒），其前无相关P波，T波与QRS主波方向相反，代偿间歇完全。

186. [batch014-M10-A1-007] 阵发性室上速急性发作时首选的治疗药物是？

- A. 口服普罗帕酮
- **B. 静脉推注腺苷** ✓
- C. 口服胺碘酮
- D. 静脉利
- E. 口服美托洛尔

答案：B | 理解 | 教材P198-P199

解析：腺苷静脉推注是PSVT急性转复的首选药物，通过短暂阻断房室结传导终止折返。无效时可选用维拉帕米或普罗帕酮静注。

187. [batch014-M10-A1-008] 室速的心电图诊断标准是连续几个以上室性早搏？

- A. 连续2个以上
- **B. 连续3个以上** ✓
- C. 连续5个以上
- D. 连续10个以上

- E. 单个即可诊断

答案：B | 记忆 | 教材P197

解析：室速定义为连续3个及以上室性期前收缩，频率大于100次/分。

188. [batch014-M10-A1-add-074] 病态窦房结综合征最可靠的诊断方法是？

- A. 常规心电图
- B. 动态心电图
- **C. 心内电生理** ✓
- D. 运动负荷试验
- E. 阿托品试验

答案：C | 记忆 | 教材P217-P218

解析：心内电生理测定SNRT和SACT是诊断病窦最可靠方法。Holter可用于筛查。

189. [batch014-M10-A1-add-075] 典型心房扑动的心房率为多少？

- A. 100至150次/分
- B. 150至250次/分
- **C. 250至350次/分** ✓
- D. 350至600次/分
- E. 大于600次/分

答案：C | 记忆 | 教材P200

解析：典型房扑心房率250-350次/分，心电图呈锯齿状F波。房颤为350-600次/分。

A2型题（4题）

190. [batch014-M10-A2-001] 女性，72岁，心悸1天。心电图：P波消失，代之以f波，RR间期绝对不齐，心室率110次/分。既往高血压史。CHADS2-VASc评分3分。首选治疗是？

- A. 观察随访
- **B. 口服抗凝药物** ✓
- C. 植入起搏器
- D. 射频消融治疗
- E. 静脉胺碘酮

答案：B | 应用 | 教材P203-P204

解析：该患者为房颤，CHADS2-VASc评分3分（≥2分），具有明确抗凝指征，应启动口服

抗凝治疗（华法林或NOAC）预防卒中。心率控制（110次/分尚可）和节律控制也需考虑。

191. [batch014-M10-A2-002] 男性，68岁，反复晕厥。心电图：P波与QRS波无固定关系，心房率80次/分，心室率35次/分。最合适的治疗是？

- A. 口服阿托品
- **B. 植入永久起搏器** ✓
- C. 静脉异丙肾上腺素
- D. 口服氨茶碱
- E. 观察随访

答案：B | 应用 | 教材P215

解析：三度AVB伴晕厥和有症状的心动过缓（心室率35次/分），是植入永久心脏起搏器的I类适应证。药物仅作为临时过渡。

192. [batch014-M10-A2-003] 青年男性阵发性心悸，ECG示PR间期0.10秒，QRS起始部可见delta波，QRS波增宽。诊断是？

- A. 房室传导阻滞
- **B. 预激综合征** ✓
- C. 束支传导阻滞
- D. 室性心动过速
- E. 房性早搏

答案：B | 应用 | 教材P210-P211

解析：PR缩短+delta波+QRS增宽是WPW典型三联征。

193. [batch014-M10-A2-add-076] 服用抗心律失常药后晕厥，ECG示QT间期延长伴多形性室速。首要处理是？

- A. 电复律治疗
- **B. 静脉注射硫酸镁** ✓
- C. 静脉利类型
- D. 口服补钾
- E. 继续观察

答案：B | 应用 | 教材P198-P199

解析：药物致QT延长伴TdP首选静脉硫酸镁2g静推，停用致QT延长药物并补钾。

A3型题（3题）

194. [batch014-A3-C3-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 窦性心动过速
- **B. 心房颤动** ✓
- C. 心房扑动
- D. 室性心动过速
- E. 阵发性室上速

答案：B | 应用 | 教材P201-P205

解析：心律绝对不齐+脉搏短绌+P波消失f波+RR不齐=心房颤动的典型表现。

195. [batch014-A3-C3-sub02] 该患者CHADS2-VASc评分至少几分？应给予？

- A. 1分不需要抗凝
- **B. 2分应启动口服抗凝** ✓
- C. 3分双联抗血小板
- D. 0分仅观察
- E. 5分需立即电复律

答案：B | 应用 | 教材P201-P205

解析：高血压(1)+糖尿病(1)+年龄 ≥ 75 (2)=至少4分 ≥ 2 分需启动口服抗凝(NOAC或华法林)预防卒中。

196. [batch014-A3-C3-sub03] 若患者血流动力学不稳定应？

- A. 口服胺碘酮转复
- **B. 同步直流电复律** ✓
- C. 静脉腺苷
- D. 继续观察
- E. 静脉西地兰

答案：B | 应用 | 教材P201-P205

解析：房颤伴血流动力学不稳定是紧急电复律的I类适应证。药物转复用于稳定患者。

B1型题（3题）

197. [batch014-B1-C4-sub01] 利多卡因属于Vaughan Williams哪一类？

- A. I 类钠通道阻 ☒
- B. II 类 β 受体阻
- C. III类钾通道阻
- D. IV类钙通道阻
- E. 其他类

答案：A | 记忆 | 教材P194-P195

解析：利多卡因为 I 类钠通道阻滞剂，主要用于室性心律失常。

198. [batch014-B1-C4-sub02] 胺碘酮属于Vaughan Williams哪一类？

- A. I 类钠通道阻
- B. II 类 β 受体阻
- C. III类钾通道阻滞剂 ☒
- D. IV类钙通道阻
- E. 其他类类型

答案：C | 记忆 | 教材P194-P195

解析：胺碘酮为III类钾通道阻滞剂，广谱抗心律失常，延长动作电位时程。

199. [batch014-B1-C4-sub03] 维拉帕米属于Vaughan Williams哪一类？

- A. I 类钠通道阻
- B. II 类 β 受体阻
- C. III类钾通道阻
- D. IV类钙通道阻滞剂 ☒
- E. 其他类类型

答案：D | 记忆 | 教材P194-P195

解析：维拉帕米为IV类钙通道阻滞剂，主要用于室上速和房颤的心率控制。

X型题（3题）

200. [batch014-M10-X-001] 以下属于 Vaughan Williams I 类抗心律失常药物的包括？

- A. 利多卡因
- B. 普罗帕酮
- C. 胺碘酮
- D. 美托洛尔

- E. 维拉帕米

答案：AB | 记忆 | 教材P194-P195

解析：利多卡因（I b类）和普罗帕酮（I c类）属于I类钠通道阻滞剂。胺碘酮为III类，美托洛尔为II类 β 受体阻滞剂，维拉帕米为IV类钙通道阻滞剂。

201. [batch014-M10-X-002] 房颤综合管理包括以下哪些方面？

- A. 卒中风险评估与抗凝
- B. 心率或节律控制
- C. 心血管危险因素管
- D. 常规预防性使用抗
- E. 生活方式干预

答案：ABCE | 理解 | 教材P203-P205

解析：房颤管理包括卒中风险评估+抗凝、心率/节律控制、危险因素管理、生活方式干预。抗生素不常规使用。

202. [batch014-M10-X-add-077] 以下属于III类抗心律失常药物的包括？

- A. 胺碘酮
- B. 索他洛尔
- C. 利多卡因
- D. 决奈达隆
- E. 普罗帕酮

答案：ABD | 记忆 | 教材P194-P195

解析：III类钾通道阻滞剂：胺碘酮、索他洛尔、决奈达隆。利多卡因Ib，普罗帕酮Ic。

M11 冠心病（23题）

A1型题（10题）

203. [batch014-M11-A1-001] 急性冠脉综合征不包括以下哪种类型？

- A. 不稳定型心绞痛
- B. ST段抬高型心肌
- C. 非ST段抬高型心
- D. 稳定型心绞痛 ☒

- E. 心源性猝死

答案：D | 记忆 | 教材P237-P238

解析：ACS包括不稳定型心绞痛、STEMI和NSTEMI。稳定型心绞痛属于慢性冠脉综合征（CCS），不属于急性冠脉综合征。心源性猝死可为ACS的表现但不作为独立分型。

204. [batch014-M11-A1-002] 稳定型心绞痛的典型疼痛持续时间通常是？

- A. 持续数秒钟
- **B. 持续3至5分钟** ✓
- C. 持续半小时以上
- D. 持续数小时
- E. 持续数天

答案：B | 记忆 | 教材P240

解析：稳定型心绞痛典型发作持续3-5分钟，休息或含服硝酸甘油可缓解。持续数秒的刺痛多为非心源性，持续半小时以上需考虑急性心肌梗死。

205. [batch014-M11-A1-003] 诊断急性心肌梗死最敏感和特异的血清标志物是？

- A. 肌酸激酶
- B. 乳酸脱氢酶
- **C. 肌钙蛋白** ✓
- D. 肌红蛋白
- E. 天冬氨酸转氨酶

答案：C | 理解 | 教材P243-P244

解析：肌钙蛋白（cTnI或cTnT）是诊断AMI最敏感和特异的标志物，心肌坏死时释放入血，3-6小时开始升高，可持续升高1-2周。CK-MB也较特异但敏感性不如肌钙蛋白。

206. [batch014-M11-A1-004] STEMI患者最关键的再灌注治疗目标是？

- A. 入院后24小时溶
- **B. 门球时间<90分钟** ✓
- C. 择期冠状动脉搭桥
- D. 口服抗凝药物
- E. 等待自行再通

答案：B | 理解 | 教材P247-P248

解析：STEMI治疗核心是尽早开通梗死相关动脉。门-球囊时间（Door-to-Balloon）应 ≤ 90 分钟，直接PCI优于溶栓。时间就是心肌，每延迟30分钟死亡率增加7.5%。

207. [batch014-M11-A1-005] 急性广泛前壁心肌梗死时，特征性心电图改变出现在哪些导联？

- A. II、III、aVF导
- **B. V1至V5导联** ☒
- C. I、aVL导联
- D. V7至V9导联
- E. V3R至V5R导

答案：B | 理解 | 教材P243-P244

解析：广泛前壁心梗ST段抬高出现在V1-V5（或V6）导联。II、III、aVF对应下壁，I、aVL对应高侧壁，V7-V9对应后壁，V3R-V5R对应右室。

208. [batch014-M11-A1-006] 急性心肌梗死后24小时内最常见的死亡原因是？

- A. 心力衰竭
- **B. 心室颤动** ☒
- C. 心脏破裂
- D. 心包炎
- E. 乳头肌断裂

答案：B | 记忆 | 教材P245-P246

解析：心室颤动是AMI后24小时内最常见的死亡原因，约占院前死亡的半数以上。心衰、心脏破裂也是并发症但发生率低于室颤。

209. [batch014-M11-A1-007] 以下哪项不是冠心病的独立危险因素？

- A. 高血压
- B. 高胆固醇
- C. 吸烟
- **D. 适量饮酒** ☒
- E. 糖尿病

答案：D | 记忆 | 教材P237

解析：适量饮酒不增加冠心病风险。高血压、高胆固醇、吸烟、糖尿病均为独立危险因

素。

210. [batch014-M11-A1-008] 冠心病二级预防中他汀类药物治疗的LDL-C目标值是？

- A. 低于1.8mmol/L ☒
- B. 低于2.6mmol/L
- C. 低于3.4mmol/L
- D. 低于4.1mmol/L
- E. 低于5.2mmol/L

答案：A | 理解 | 教材P239

解析：冠心病二级预防LDL-C目标小于1.8mmol/L（70mg/dL）或降幅至少50%。

211. [batch014-M11-A1-add-078] 急性心梗后CK-MB升高的典型时间窗是？

- A. 立即升高出现
- B. 4至6小时开始升高 ☒
- C. 12小时后才升高
- D. 24小时后升高
- E. 48小时达峰

答案：B | 记忆 | 教材P244

解析：CK-MB于AMI后4-6h升高，16-24h达峰，3-4d正常。肌钙蛋白持续更久。

212. [batch014-M11-A1-add-079] 下壁心梗合并低血压和颈静脉怒张时应考虑？

- A. 左心衰竭
- B. 右心室梗死 ☒
- C. 心包填塞
- D. 肺栓塞
- E. 主动脉夹层

答案：B | 理解 | 教材P245

解析：下壁心梗+低血压+颈静脉怒张+双肺清晰=右室梗死三联征。需大量补液而非利尿。

A2型题（4题）

213. [batch014-M11-A2-001] 男性，58岁，胸骨后压榨性疼痛2小时，含服硝酸甘油不缓解。心电图示V1-V4导联ST段弓背向上抬高。最可能的诊断是？

- A. 不稳定型心绞痛
- **B. 急性前壁心肌梗死** ✓
- C. 急性心包炎
- D. 主动脉夹层
- E. 急性肺栓塞

答案：B | 应用 | 教材P243-P247

解析：持续性胸痛+硝酸甘油不缓解+V1-V4 ST段弓背向上抬高，符合急性前壁STEMI的经典表现。不稳定型心绞痛无ST段抬高和心肌坏死标志物升高。心包炎ST段呈凹面向上广泛抬高。

214. [batch014-M11-A2-002] AMI后第3天，突然出现心前区粗糙收缩期杂音伴心力衰竭加重。最可能的诊断是？

- A. 心包摩擦音
- **B. 室间隔穿孔** ✓
- C. 乳头肌功能
- D. 心脏游离壁破裂
- E. 左室附壁血栓

答案：B | 分析 | 教材P246-P247

解析：AMI后新出现的粗糙全收缩期杂音+心衰加重，高度提示室间隔穿孔（机械并发症），多发生于心梗后3-7天。需紧急外科手术。

215. [batch014-M11-A2-003] 男性，62岁，近3天反复静息时胸痛，每次持续10-15分钟，ECG示ST段压低0.2mV，肌钙蛋白正常。处理策略是？

- A. 门诊随访观察
- B. 住院药物保守治疗
- **C. 早期侵入策略** ✓
- D. 立即溶栓治疗
- E. 门诊运动负荷试验

答案：C | 应用 | 教材P241-P242

解析：高危UA（静息痛+ST段压低）应行早期侵入策略（24小时内冠脉造影+PCI）。溶栓仅用于STEMI，对UA/NSTEMI有害。

216. [batch014-M11-A2-add-080] 胸痛6小时，ECG示ST段压低0.3mV，肌钙蛋白显著升高。最佳策略是？

- A. 立即溶栓治疗
- **B. 24小时内早期侵入** ✓
- C. 择期冠脉造影
- D. 药物保守治疗
- E. 急诊CABG

答案：B | 应用 | 教材P241-P242

解析：NSTEMI高危患者应在24h内行早期侵入策略。溶栓对NSTEMI有害无益。

A3型题（3题）

217. [batch014-A3-C1-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 不稳定型心绞痛
- **B. 急性前壁STEMI** ✓
- C. 急性下壁STEMI
- D. 主动脉夹层
- E. 急性肺栓塞

答案：B | 应用 | 教材P243-P250

解析：持续胸痛+硝酸甘油无效+V1-V4 ST段弓背向上抬高=急性前壁STEMI。主动脉夹层有撕裂样痛+双上肢血压差。

218. [batch014-A3-C1-sub02] 首选的治疗措施是？

- A. 溶栓治疗
- **B. 急诊直接PCI** ✓
- C. 择期冠脉造影
- D. 保守药物治疗
- E. 急诊CABG

答案：B | 应用 | 教材P243-P250

解析：发病<12h的STEMI首选直接PCI(D-to-B≤90min)。无PCI条件且预期转运>120min才选溶栓。

219. [batch014-A3-C1-sub03] PCI术后应长期使用的药物不包括？

- A. 阿司匹林
- B. 替格瑞洛
- C. ACEI
- **D. 非二氢吡啶类CC** 
- E. 高剂量他汀

答案：D | 分析 | 教材P243-P250

解析：STEMI术后标准用药：阿司匹林+P2Y12抑制剂+ACEI+β阻滞剂+他汀。非二氢吡啶类CCB(维拉帕米)不改善预后。

B1型题（4题）

220. [batch014-M11-B1-001] 胸痛在休息时可发作，含服硝酸甘油效果欠佳，心电图ST段压低，肌钙蛋白正常，属于？

- A. 稳定型心绞痛
- **B. 不稳定型心绞痛** 
- C. 非ST段抬高型心
- D. ST段抬高型心肌梗死
- E. 变异型心绞痛

答案：B | 理解 | 教材P240-P241

解析：静息时发作、硝酸甘油效果欠佳、ST段压低但肌钙蛋白正常，符合不稳定型心绞痛（UA）特征。NSTEMI肌钙蛋白升高，STEMI有ST段抬高，变异型心绞痛ST段一过性抬高。

221. [batch014-B1-C1-sub01] 劳累诱发且休息或含服硝酸甘油可缓解，属于？

- **A. 稳定型心绞痛由劳累诱发** 
- B. 不稳定型心绞痛
- C. 变异型心绞痛
- D. 非ST段抬高心梗
- E. ST段抬高心梗

答案：A | 理解 | 教材P240-P244

解析：稳定型心绞痛由劳累诱发，休息或硝酸甘油可缓解，是CCS的典型表现。

222. [batch014-B1-C1-sub02] 静息时发作且心电图一过性ST段抬高，肌钙蛋白正常，属于？

- A. 稳定型心绞痛
- B. 不稳定型心绞痛
- **C. 变异型心绞痛** ✓
- D. 非ST段抬高心梗
- E. ST段抬高心梗

答案：C | 应用 | 教材P240-P244

解析：变异型心绞痛(Prinzmetal)静息发作，ST段一过性抬高(冠脉痉挛)，肌钙蛋白正常。

223. [batch014-B1-C1-sub03] 静息时发作且ST段压低伴肌钙蛋白升高，属于？

- A. 稳定型心绞痛
- B. 不稳定型心绞痛
- C. 变异型心绞痛
- **D. 非ST段抬高心梗** ✓
- E. ST段抬高心梗

答案：D | 应用 | 教材P240-P244

解析：ST段压低+肌钙蛋白升高符合NSTEMI诊断标准。

X型题（2题）

224. [batch014-M11-X-001] 急性心肌梗死的基础药物治疗包括以下哪些？

- A. 双联抗血小板治疗
- B. 抗凝治疗
- C. β 受体阻滞剂
- D. ACEI类药物
- E. 高剂量他汀

答案：ABCDE | 理解 | 教材P248-P250

解析：AMI基础药物治疗包括：双联抗血小板（阿司匹林+P2Y₁₂抑制剂）、抗凝（肝素）、 β 受体阻滞剂、ACEI/ARB和高强度他汀。全部选项均为AMI标准治疗。

225. [batch014-M11-X-add-081] 急性心梗的机械并发症包括？

- A. 乳头肌断裂
- B. 室间隔穿孔
- C. 心脏游离壁破

- D. 左室室壁瘤
- E. 心包炎

答案：ABCD | 记忆 | 教材P246-P247

解析：机械并发症：乳头肌断裂、室间隔穿孔、游离壁破裂、室壁瘤。心包炎为炎症性。

M12 高血压（18题）

A1型题（8题）

226. [batch014-M12-A1-001] 根据中国高血压防治指南，高血压的诊断标准是？

- A. 血压 $\geq 130/80$ mmHg
- **B. 血压 $\geq 140/90$ mmHg** ✓
- C. 血压 $\geq 150/95$ mmHg
- D. 血压 $\geq 160/100$ mmHg
- E. 血压 $\geq 120/80$ mmHg

答案：B | 记忆 | 教材P253

解析：中国高血压诊断标准为未使用降压药情况下，诊室收缩压 ≥ 140 mmHg和/或舒张压 ≥ 90 mmHg。美国2017年指南下调为 $\geq 130/80$ mmHg。

227. [batch014-M12-A1-002] 血压165/105mmHg属于高血压几级？

- A. 正常高值血压
- B. 1级高血压轻度
- **C. 2级高血压中度** ✓
- D. 3级高血压重度
- E. 单纯收缩期高血压

答案：C | 记忆 | 教材P253

解析：2级高血压（中度）：收缩压160-179mmHg和/或舒张压100-109mmHg。165/105mmHg的收缩压和舒张压均符合2级标准。

228. [batch014-M12-A1-003] 原发性高血压发病机制中最重要的一环是？

- A. 交感神经系统激活
- **B. RAAS系统激活** ✓
- C. 钠盐摄入过

- D. 胰岛素抵抗
- E. 血管内皮功能异常

答案：B | 理解 | 教材P254-P255

解析：RAAS激活是原发性高血压最重要的发病机制，Ang II 通过缩血管和促醛固酮分泌升高血压。交感激活和钠摄入也重要但RAAS为核心环节。

229. [batch014-M12-A1-004] 以下哪种降压药物禁用于双侧肾动脉狭窄患者？

- A. 钙通道阻滞剂
- **B. ACEI** ✓
- C. 噻嗪类利尿剂
- D. β 受体阻滞剂
- E. α 受体阻滞剂

答案：B | 理解 | 教材P257-P258

解析：ACEI/ARB阻断Ang II 扩张出球小动脉，在双侧肾动脉狭窄时可使肾小球滤过率急剧下降，诱发急性肾衰竭，属绝对禁忌。

230. [batch014-M12-A1-005] 高血压急症治疗时，降压速度的原则是？

- A. 立即降至正常范围
- **B. 首小时降压** ✓
- C. 24小时内缓慢降
- D. 无需着急降压
- E. 降至收缩压90mmHg

答案：B | 理解 | 教材P260-P261

解析：高血压急症应静脉给药，第1小时平均动脉压降幅不超过25%，随后2-6小时内降至160/100mmHg左右。过快降压可致脏器灌注不足。

231. [batch014-M12-A1-006] 高血压最常见且最早的靶器官损害是？

- A. 肾脏损害
- **B. 左心室肥厚** ✓
- C. 脑血管损害
- D. 视网膜损害
- E. 周围血管损害

答案：B | 记忆 | 教材P253-P254

解析：左心室肥厚是高血压最早和最常见的靶器官损害。

232. [batch014-M12-A1-add-082] 高血压联合治疗中不推荐以下哪种组合？

- A. ACEI联合CCB
- B. ARB联合利尿剂
- **C. ACEI联合ARB** ✓
- D. CCB联合利尿剂
- E. CCB联合 β 阻滞剂

答案：C | 理解 | 教材P258-P259

解析：ACEI+ARB双重RAAS阻断增加肾损害和高血钾风险，不推荐。

233. [batch014-M12-A1-add-083] 嗜铬细胞瘤最特征性的临床表现是？

- A. 持续性血压升高
- **B. 阵发性血压升高** ✓
- C. 低血压休克
- D. 体位性低血压
- E. 血压正病变

答案：B | 记忆 | 教材P256

解析：阵发性高血压伴头痛心悸出汗三联征是嗜铬细胞瘤最特征性表现。

A2型题（3题）

234. [batch014-M12-A2-001] 青年女性，血压持续升高伴低血钾，血醛固酮升高而肾素活性降低，肾上腺CT示左侧结节。最可能的诊断是？

- A. 肾动脉狭窄
- **B. 原发性醛固酮增** ✓
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 库欣综合征
- E. 主动脉缩窄

答案：B | 应用 | 教材P255-P256

解析：高血压+低血钾+高醛固酮+低肾素+肾上腺结节，是原发性醛固酮增多症（Conn综合征）的典型表现。肾动脉狭窄表现为高肾素。

235. [batch014-M12-A2-002] 高血压患者突发剧烈头痛伴视物模糊，血压230/130mmHg，眼底检查示视乳头水肿。诊断是？

- A. 高血压1级
- B. 高血压急症
- **C. 恶性高血压** ☒
- D. 高血压亚急症
- E. 继发性高血压

答案：C | 应用 | 教材P260

解析：血压显著升高+视乳头水肿是恶性高血压的特征性表现。

236. [batch014-M12-A2-add-084] 三药联合含利尿剂后血压仍160/100mmHg，下一步应？

- A. 直接加第四种药物
- **B. 排查继发性高血压** ☒
- C. 增加利尿剂剂量
- D. 更换更强效药物
- E. 建议观察

答案：B | 应用 | 教材P259-P260

解析：难治性高血压应首先排查继发原因：肾动脉狭窄、原醛、OSA等。

A3型题（2题）

237. [batch014-A3-C4-sub01] 该患者应诊断为？

- A. 高血压1级
- **B. 恶性高血压** ☒
- C. 高血压亚急症
- D. 继发性高血压
- E. 单纯收缩期高血压

答案：B | 应用 | 教材P260-P261

解析：血压显著升高+视乳头水肿(K-W IV级)=恶性高血压(急进型高血压)。靶器官损害已存在。

238. [batch014-A3-C4-sub02] 首选的降压策略是？

- A. 口服硝苯地平快速降压
- **B. 静脉泵入硝普钠控制降** ✓
- C. 舌下含服卡托普利
- D. 观察等待自行下降
- E. 静脉输注硝普钠

答案：B | 应用 | 教材P260-P261

解析：高血压急症应静脉给药，首小时MAP降幅 $\leq 25\%$ 后渐降至160/100mmHg。口服硝苯地平可致血压骤降引起脑梗死。

B1型题（4题）

239. [batch014-B1-C2-sub01] 合并糖尿病肾病的高血压患者首选？

- **A. ACEI** ✓
- B. 钙通道阻滞剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 噻嗪类利尿剂
- E. α 受体阻滞剂

答案：A | 理解 | 教材P256-P259

解析：ACEI/ARB可减少蛋白尿延缓肾功能恶化，是糖尿病肾病合并高血压的首选。

240. [batch014-B1-C2-sub02] 合并快速性心房颤动的高血压患者首选？

- A. ACEI
- B. 钙通道阻滞剂
- **C. β 受体阻滞剂** ✓
- D. 噻嗪类利尿剂
- E. α 受体阻滞剂

答案：C | 理解 | 教材P256-P259

解析： β 阻滞剂可控制心室率，是合并快室率房颤高血压患者的优选。

241. [batch014-B1-C2-sub03] 双侧肾动脉狭窄患者应避免使用？

- **A. ACEI** ✓
- B. 钙通道阻滞剂
- C. β 受体阻滞剂

- D. 噻嗪类利尿剂
- E. α 受体阻滞剂

答案：A | 理解 | 教材P256-P259

解析：双侧肾动脉狭窄时ACEI/ARB可致急性肾衰，属绝对禁忌。

242. [batch014-B1-C2-sub04] 合并痛风的高血压患者慎用？

- A. ACEI
- B. 钙通道阻滞剂
- C. β 受体阻滞剂
- **D. 噻嗪类利尿剂** ✓
- E. α 受体阻滞剂

答案：D | 理解 | 教材P256-P259

解析：噻嗪类利尿剂可升高血尿酸诱发痛风，痛风患者慎用。

X型题（1题）

243. [batch014-M12-X-001] 以下属于高血压一线治疗药物的包括？

- A. 血管紧张素转换酶
- B. 钙通道阻滞剂
- C. 噻嗪类利尿剂
- D. 中枢性降压药
- E. 血管紧张素受体阻

答案：ABCE | 记忆 | 教材P256-P258

解析：高血压一线药物包括ACEI、ARB、CCB、噻嗪类利尿剂和 β 受体阻滞剂五大类。中枢性降压药（如可乐定）为二线或特殊情况使用。

M13 心肌疾病（9题）

A1型题（4题）

244. [batch014-M13-A1-001] 扩张型心肌病最具特征性的病理改变是？

- A. 心室壁显著增厚
- **B. 心腔扩大伴室壁变** ✓
- C. 心肌淀粉样变性

- D. 心内膜纤维化
- E. 心肌炎性浸润

答案：B | 记忆 | 教材P269-P270

解析：扩张型心肌病特征为心腔显著扩大（尤其左室）、心室壁变薄、心肌收缩功能弥漫性减退，病理可见心肌细胞肥大伴间质纤维化。

245. [batch014-M13-A1-002] 肥厚型心肌病最具特征性的体征是？

- A. 主动脉瓣区舒张期杂音
- **B. 胸骨左缘收缩期喷射性杂音** ✓
- C. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- D. 肺动脉瓣区收缩期杂音
- E. 三尖瓣区全收缩期杂音

答案：B | 理解 | 教材P271-P272

解析：HCM因室间隔非对称性肥厚导致左室流出道梗阻，产生胸骨左缘第3-4肋间收缩期喷射性杂音。含服硝酸甘油或Valsalva动作可使杂音增强。

246. [batch014-M13-A1-003] 扩张型心肌病心衰的标准药物治疗不包括？

- A. ACEI或ARB
- B. beta阻滞剂、MRA、利尿剂
- **C. 钙通道阻滞剂选项** ✓
- D. 螺内酯类型选项药物
- E. 袢利尿剂治疗选项

答案：C | 理解 | 教材P270

解析：DCM心衰标准治疗含ACEI/ARB、beta阻滞剂、MRA、利尿剂，非二氢吡啶类CCB有负性肌力作用不推荐。

247. [batch014-M13-A1-add-085] 限制型心肌病临床表现最类似哪种疾病？

- A. 扩张型心肌病
- **B. 缩窄性心包炎** ✓
- C. 肥厚型心肌病
- D. 急性心包炎
- E. 肺源性心脏病

答案：B | 记忆 | 教材P273-P274

解析：限制型心肌病因充盈受限表现酷似缩窄性心包炎。鉴别需MRI或心肌活检。

A2型题（1题）

248. [batch014-M13-A2-001] 青年运动员，运动中突发晕厥。其父40岁时猝死。心脏超声示室间隔厚度18mm，左室后壁10mm。最可能的诊断是？

- A. 扩张型心肌病
- **B. 肥厚型心肌病** ✓
- C. 限制型心肌病
- D. 高血压心脏病
- E. 运动员心脏

答案：B | 应用 | 教材P271-P273

解析：青年+运动晕厥+猝死家族史+超声示非对称性室间隔肥厚（室间隔/后壁>1.3），是HCM的经典表现。HCM是年轻运动员猝死最常见的原因。

B1型题（3题）

249. [batch014-B1-C3-sub01] 心腔扩大伴收缩功能减退，超声示左室舒张末径显著增大，属于？

- **A. 扩张型心肌病** ✓
- B. 肥厚型心肌病
- C. 限制型心肌病
- D. 致心律失常
- E. 应激性心肌病

答案：A | 应用 | 教材P269-P274

解析：DCM特征为心腔显著扩大+收缩功能减退，左室舒张末径常>55mm。

250. [batch014-B1-C3-sub02] 室间隔非对称性肥厚伴左室流出道梗阻，属于？

- A. 扩张型心肌病
- **B. 肥厚型心肌病** ✓
- C. 限制型心肌病
- D. 致心律失常
- E. 应激性心肌病

答案：B | 应用 | 教材P269-P274

解析：HCM特征为室间隔非对称性肥厚(室间隔/后壁 ≥ 1.3)伴或不伴流出道梗阻。

251. [batch014-B1-C3-sub03] 表现为右心衰为主且心影不大类似缩窄性心包炎，属于？

- A. 扩张型心肌病
- B. 肥厚型心肌病
- **C. 限制型心肌病** ✓
- D. 致心律失常
- E. 应激性心肌病

答案：C | 应用 | 教材P269-P274

解析：RCM因心肌僵硬充盈受限，表现酷似缩窄性心包炎，右心衰为主。

X型题（1题）

252. [batch014-M13-X-001] 肥厚型心肌病的治疗药物包括以下哪些？

- A. beta受体
- B. 非二氢吡啶类
- C. 硝酸酯类药物
- D. 洋地黄类药物
- E. 丙吡胺

答案：ABE | 理解 | 教材P272-P273

解析：HCM药物含beta阻滞剂、维拉帕米和丙吡胺。硝酸酯和洋地黄可加重流出道梗阻。

M14 心脏瓣膜病（12题）

A1型题（4题）

253. [batch014-M14-A1-001] 二尖瓣狭窄最具特征性的听诊发现是？

- A. 心尖部收缩期吹风样杂音
- **B. 心尖部舒张期隆隆样杂音** ✓
- C. 主动脉瓣区舒张期杂音
- D. 胸骨左缘收缩期杂音
- E. 肺动脉瓣区喷射性杂音

答案：B | 记忆 | 教材P283-P284

解析：心尖部低调舒张期隆隆样杂音（伴舒张期震颤）是二尖瓣狭窄的特征性体征。心尖部收缩期杂音见于二尖瓣关闭不全。

254. [batch014-M14-A1-002] 以下哪项不属于慢性主动脉瓣关闭不全的周围血管征？

- A. 水冲脉体征选项
- B. 枪击音体征选项
- C. 毛细血管搏动征、点头征
- **D. 奇脉体征选项** ✓
- E. 点头征类型选项

答案：D | 记忆 | 教材P288-P289

解析：主动脉瓣关闭不全的周围血管征包括水冲脉、枪击音、毛细血管搏动征、点头征等，均因脉压增大。奇脉见于心包填塞和重症哮喘。

255. [batch014-M14-A1-003] 主动脉瓣狭窄的典型三联征是？

- **A. 胸痛加晕厥加心衰** ✓
- B. 胸痛加心悸加水肿
- C. 晕厥加咯血加发热
- D. 心衰加发绀加心悸
- E. 胸痛加贫血加发热

答案：A | 记忆 | 教材P286-P287

解析：主窄典型三联征：心绞痛、晕厥和心力衰竭。出现症状后预后差。

256. [batch014-M14-A1-add-086] 慢性二尖瓣关闭不全最可靠的诊断方法是？

- A. 心电图
- B. 胸部X线
- **C. 超声心动图** ✓
- D. 心导管
- E. 心脏核磁共振

答案：C | 理解 | 教材P285

解析：超声心动图尤其彩色多普勒是评估二尖瓣反流最可靠的无创方法。

A2型题（2题）

257. [batch014-M14-A2-001] 女性，40岁，进行性呼吸困难。心尖部闻及舒张期隆隆样杂音伴第一心音亢进，胸片示左心房增大。最可能的病因是？

- A. 风湿性心脏病 ☒
- B. 退行性瓣膜病
- C. 感染性心内膜炎
- D. 先天性瓣膜畸形
- E. 系统性红斑狼疮

答案：A | 应用 | 教材P283

解析：中年女性+心尖部舒张期杂音+左房增大，典型二尖瓣狭窄表现。我国二尖瓣狭窄最常见病因仍为风湿性心脏病，多见于女性。

258. [batch014-M14-A2-add-087] 二尖瓣脱垂患者拔牙后发热2周，超声示二尖瓣赘生物。血培养最可能分离出？

- A. 金黄色葡萄
- B. 草绿色链球菌 ☒
- C. 肠球菌类型
- D. 真菌相关表现
- E. 革兰阴性

答案：B | 应用 | 教材P291-P292

解析：口腔操作后亚急性IE最常见病原体为草绿色链球菌。急性IE以金葡萄菌为主。

A3型题（2题）

259. [batch014-A3-C5-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 风湿热类型
- B. 感染性心内膜炎 ☒
- C. 败血症病变
- D. 系统性红斑狼
- E. 淋巴瘤病变

答案：B | 应用 | 教材P291-P295

解析：口腔操作史+发热+新出现杂音+栓塞表现(甲床出血)+血培养阳性(Duke标准)=感染性心内膜炎。

260. [batch014-A3-C5-sub02] 超声心动图最有价值的发现是？

- A. 左室肥厚
- **B. 二尖瓣赘生物** ✓
- C. 心包积液
- D. 左房增大
- E. 主动脉瓣钙化

答案：B | 应用 | 教材P291-P295

解析：经胸或经食管超声发现瓣膜赘生物是IE诊断的主要标准之一，对确诊和治疗决策至关重要。

B1型题（3题）

261. [batch014-B1-C5-sub01] 二尖瓣狭窄最具特征性的杂音是？

- **A. 心尖部舒张期隆隆样杂音** ✓
- B. 心尖部收缩期吹风样杂音
- C. 主动脉瓣区收缩期喷射性杂音
- D. 主动脉瓣区舒张期叹气样杂音
- E. 胸骨左缘收缩期喷射性杂音

答案：A | 记忆 | 教材P283-P289

解析：心尖部低调舒张期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄特征，伴S1亢进和开瓣音。

262. [batch014-B1-C5-sub02] 主动脉瓣关闭不全最具特征性的杂音是？

- A. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- B. 心尖部收缩期吹风样杂音
- C. 主动脉瓣区收缩期喷射性杂音
- **D. 主动脉瓣区舒张期叹气样杂音** ✓
- E. 胸骨左缘收缩期喷射性杂音

答案：D | 记忆 | 教材P283-P289

解析：主动脉瓣区舒张期叹气样递减型杂音是主闭特征，前倾坐位呼气末最清楚。

263. [batch014-B1-C5-sub03] 肥厚型心肌病最具特征性的杂音是？

- A. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- B. 心尖部收缩期吹风样杂音

- C. 主动脉瓣区收缩期喷射性杂音
- D. 主动脉瓣区舒张期叹气样杂音
- E. 胸骨左缘收缩期喷射性杂音 ☒

答案：E | 理解 | 教材P283-P289

解析：胸骨左缘3-4肋间收缩期喷射性杂音是HCM流出道梗阻的特征。

X型题（1题）

264. [batch014-M14-X-001] 以下哪些是二尖瓣脱垂的听诊特征？

- A. 收缩中期喀喇音加收缩晚期杂音
- B. 收缩晚期杂音表现
- C. 舒张期隆隆样杂音
- D. valsalva使喀喇音
- E. 下蹲使杂音增强

答案：ABD | 记忆 | 教材P284-P285

解析：二尖瓣脱垂特征为收缩中期喀喇音加收缩晚期杂音，Valsalva使左室容量减小致喀喇音提前。

M15 心包疾病（8题）

A1型题（5题）

265. [batch014-M15-A1-001] 急性心包炎最具特征性的症状是？

- A. 压榨性胸痛
- B. 前倾位 ☒
- C. 撕裂样胸痛
- D. 烧心感
- E. 针刺样局部疼

答案：B | 记忆 | 教材P316

解析：急性心包炎胸痛特点为锐痛，坐位和前倾位可缓解，仰卧位加重。压榨性胸痛多见于心绞痛，撕裂样胸痛见于主动脉夹层。

266. [batch014-M15-A1-002] 急性心包炎典型心电图表现是？

- A. ST段弓背向上抬

- **B. 广泛ST段凹面向上抬高** ✓
- C. 深而宽的病理Q波
- D. QT间期显著延长
- E. 高尖T波改变

答案：B | 记忆 | 教材P316-P317

解析：急性心包炎心电图特征为广泛导联（除aVR外）ST段凹面向上抬高，无对应性ST段压低。AMI的ST段呈弓背向上抬高且有对应性改变。

267. [batch014-M15-A1-003] 心包填塞的Beck三联征包括？

- A. 高血压加心音遥远加发热
- **B. 低血压加心音遥远加颈静脉怒张** ✓
- C. 发热加心包摩擦音加胸痛
- D. 胸痛加ST段抬高加奇脉
- E. 奇脉加肝大加双下肢水肿

答案：B | 理解 | 教材P318-P319

解析：Beck三联征：低血压（心排血量降低）、心音遥远（心包积液）、颈静脉怒张（静脉回流受阻）。奇脉也是心包填塞的重要体征。

268. [batch014-M15-A1-004] 缩窄性心包炎最具特征性的体征是？

- A. 心尖部舒张期杂音
- **B. Kussmaul征** ✓
- C. 主动脉瓣区杂音
- D. 心包摩擦音
- E. 第三心音奔马律

答案：B | 记忆 | 教材P319

解析：Kussmaul征（吸气时颈静脉压力反常升高）是缩窄性心包炎特征性体征。

269. [batch014-M15-A1-add-088] 大量心包积液最具特征性的心电图表现是？

- A. ST段抬高
- **B. 电交替现象** ✓
- C. QT间期延长
- D. PR间期延长
- E. 左室高电压

答案：B | 理解 | 教材P318

解析：电交替（QRS振幅交替变化）是大量心包积液的特征性表现。

A2型题（1题）

270. [batch014-M15-A2-001] 青年男性发热胸痛3天，前倾位可缓解。ECG示广泛ST段凹面向上抬高。诊断是？

- A. 急性心肌梗死
- **B. 急性心包炎** ✓
- C. 主动脉夹层
- D. 肺栓塞
- E. 稳定型心绞痛

答案：B | 应用 | 教材P316-P317

解析：青年发热加前倾缓解胸痛加广泛ST段凹面向上抬高，符合急性心包炎。

A3型题（2题）

271. [batch014-A3-C6-sub01] 该患者的Beck三联征包括？

- A. 高血压+心音遥远+发热
- **B. 低血压+心音遥远+颈静脉怒张** ✓
- C. 发热+心包摩擦音+胸痛
- D. 胸痛+ST段抬高+奇脉
- E. 呼吸困难+发绀+咯血

答案：B | 应用 | 教材P318-P319

解析：Beck三联征：低血压(心排低)+心音遥远(积液)+颈静脉怒张(回流受阻)=心包填塞经典表现。

272. [batch014-A3-C6-sub02] 确诊后首选的紧急治疗是？

- A. 静脉补液扩容
- **B. 心包穿刺引流减压** ✓
- C. 紧急开胸手术
- D. 利尿剂治疗
- E. 血管活性药物

答案：B | 应用 | 教材P318-P319

解析：心包填塞确诊后应紧急心包穿刺引流减压。补液和血管活性药仅作为术前过渡。

M16 心脏骤停与猝死（6题）

A1型题（5题）

273. [batch014-M16-A1-001] 判断心脏骤停最重要的依据是？

- A. 瞳孔散大固定
- **B. 意识丧失加大动脉** ✓
- C. 呼吸停止
- D. 面色发绀
- E. 血压测病变

答案：B | 记忆 | 教材P330-P331

解析：意识突然丧失+大动脉（颈动脉或股动脉）搏动消失是判断心脏骤停最关键的体征，应在10秒内确认。瞳孔散大等为后续表现。

274. [batch014-M16-A1-002] 成人基础生命支持中，胸外按压与通气的比例是？

- A. 按压15次:通气1次
- **B. 按压30次:通气2次** ✓
- C. 按压5次通气1次
- D. 连续按压不中断通气
- E. 按压15次:通气2次

答案：B | 理解 | 教材P332-P333

解析：成人单人施救者CPR按压与通气比为30:2，按压频率100-120次/分，按压深度5-6cm。重点强调高质量胸外按压。

275. [batch014-M16-A1-003] 主动脉夹层最典型的临床表现是？

- A. 胸骨后压榨性疼痛
- **B. 突发撕裂样剧烈胸** ✓
- C. 钝痛伴呼吸困难
- D. 针刺样胸膜痛
- E. 烧灼样上腹部疼痛

答案：B | 理解 | 教材P337-P338

解析：主动脉夹层的特征为突发、剧烈、撕裂样或刀割样胸背部疼痛，疼痛一开始即达高峰，可沿主动脉走行放射。压榨样痛为心梗特征。

276. [batch014-M16-A1-004] 院外心脏骤停最常见的初始可除颤心律是？

- A. 窦性心动过速
- **B. 心室颤动** 
- C. 心室停搏
- D. 心房颤动
- E. 三度房室传导阻滞

答案：B | 记忆 | 教材P330

解析：心室颤动是院外心脏骤停最常见的初始可除颤心律，是最关键的早期治疗窗口。

277. [batch014-M16-A1-add-089] 成人室颤除颤时双相波除颤器首次推荐能量为？

- A. 100J
- **B. 150至200J** 
- C. 300J
- D. 360J
- E. 50J能量

答案：B | 记忆 | 教材P332

解析：双相波推荐150-200J，单相波360J。除颤后立即CPR 2分钟再查心律。

A2型题（1题）

278. [batch014-M16-A2-001] 男性，55岁，高血压史。突发胸背部撕裂样剧痛，双上肢血压差40mmHg。胸部CT示主动脉内膜片影。应立即给予的治疗是？

- A. 口服抗凝治疗
- **B. 静脉β阻滞剂联合** 
- C. 急诊冠状动脉造影
- D. 立即溶栓治疗
- E. 口服阿司匹林

答案：B | 分析 | 教材P338-P339

解析：主动脉夹层急性期应迅速控制心率和血压（HR<60次/分，SBP 100-120mmHg），静

M17 贫血概述（10题）

A1型题（5题）

279. [batch014-M17-A1-001] 我国成年男性贫血的诊断标准是血红蛋白低于？

- A. 110g/L
- **B. 120g/L** ✓
- C. 130g/L
- D. 100g/L
- E. 90g/L

答案：B | 记忆 | 教材P542

解析：我国成年男性Hb<120g/L、成年女性Hb<110g/L、孕妇Hb<100g/L可诊断为贫血。

280. [batch014-M17-A1-002] 按红细胞形态分类，缺铁性贫血属于？

- A. 大细胞性贫血
- B. 正细胞性贫血
- **C. 小细胞低色素性贫血** ✓
- D. 单纯小细胞性贫血
- E. 溶血性贫血

答案：C | 记忆 | 教材P542-P543

解析：缺铁性贫血为小细胞低色素性贫血（MCV<80fl，MCHC<32%）。巨幼细胞性贫血为大细胞性，再障为正细胞性。

281. [batch014-M17-A1-003] 贫血最常见的临床表现是？

- A. 黄疸
- B. 酱油色尿
- **C. 疲乏无力** ✓
- D. 骨痛
- E. 发热

答案：C | 记忆 | 教材P542

解析：疲乏、无力、头晕是贫血最常见的症状，因组织缺氧所致。黄疸见于溶血性贫血，酱油色尿见于血管内溶血。

282. [batch014-M17-A1-004] 根据Hb水平，重度贫血的标准是？

- A. Hb低于30g/L
- **B. Hb30至59g/L** ✓
- C. Hb60至90g/L
- D. Hb低于90g/L
- E. Hb低于120g/L

答案：B | 记忆 | 教材P542

解析：贫血分级：轻度Hb>90g/L，中度60-90g/L，重度30-59g/L，极重度<30g/L。

283. [batch014-M17-A1-005] MCV正常、MCHC正常的贫血属于？

- A. 小细胞低色素性贫血
- **B. 正细胞正色素性贫血** ✓
- C. 大细胞性贫血
- D. 单纯小细胞性贫血
- E. 低色素性贫血

答案：B | 理解 | 教材P542-P543

解析：MCV正常(80-100fl)+MCHC正常(32-35%)为正细胞正色素性贫血，见于再障、溶血性贫血、急性失血等。

A2型题（1题）

284. [batch014-M17-A2-add-049] 患者Hb=85g/L，MCV=105fl，大细胞性贫血。首选检查是？

- A. 骨髓穿刺检查
- **B. 叶酸和维生素B12测** ✓
- C. 血红蛋白电泳
- D. 血清铁蛋白
- E. 溶血相关检查项目

答案：B | 应用 | 教材P542-P543

解析：大细胞性贫血(MCV>100fl)最常见原因为巨幼贫，首选查叶酸和B12水平。

B1型题（3题）

285. [batch014-B1-BL1-sub01] 小细胞低色素性贫血，血清铁蛋白 $<12\mu\text{g/L}$ ，属于？

- A. 缺铁性贫血 ☒
- B. 巨幼细胞性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 慢性病贫血

答案：A | 应用 | 教材P542-P549

解析：MCV $<80\text{fl}$ +SF降低+小细胞低色素符合缺铁性贫血(IDA)。

286. [batch014-B1-BL1-sub02] 大细胞性贫血，血清维生素B12降低，属于？

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血 ☒
- C. 再生障碍性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 慢性病贫血

答案：B | 应用 | 教材P542-P549

解析：MCV $>100\text{fl}$ +VB12降低+大细胞性符合巨幼细胞性贫血。

287. [batch014-B1-BL1-sub03] 正细胞正色素性贫血，全血细胞减少，骨髓增生减低，属于？

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血
- C. 再生障碍性贫血 ☒
- D. 溶血性贫血
- E. 慢性病贫血

答案：C | 应用 | 教材P542-P549

解析：MCV正常+全血减少+骨髓增生减低符合再生障碍性贫血。

X型题 (1题)

288. [batch014-M17-X-001] 以下属于大细胞性贫血的疾病包括？

- A. 巨幼细胞性贫血
- B. 骨髓增生异

- C. 缺铁性贫血
- D. 肝病性贫血
- E. 再生障碍性贫血

答案：ABD | 记忆 | 教材P542-P543

解析：巨幼贫、MDS和肝病性贫血均可表现为大细胞性（MCV>100fl）。缺铁贫为小细胞低色素性，再障为正细胞性。

M18 缺铁性贫血（12题）

A1型题（6题）

289. [batch014-M18-A1-001] 体内贮存铁的主要形式是？

- A. 血红蛋白铁
- B. 铁蛋白和含铁 ☒
- C. 肌红蛋白铁
- D. 转铁蛋白结合铁
- E. 血清铁病变

答案：B | 理解 | 教材P543-P544

解析：铁蛋白和含铁血黄素是体内贮存铁的主要形式，存在于肝、脾、骨髓等单核巨噬细胞系统中。转铁蛋白结合铁为运输铁。

290. [batch014-M18-A1-002] 成人缺铁性贫血最常见的病因是？

- A. 摄入不足
- B. 慢性失血 ☒
- C. 吸收障碍
- D. 需要量增加
- E. 遗传性疾病

答案：B | 记忆 | 教材P544

解析：慢性失血是成人缺铁性贫血最常见的病因，如消化道出血、月经过多等。摄入不足多见于婴幼儿。

291. [batch014-M18-A1-003] 缺铁性贫血时，血清铁蛋白的诊断界值是？

- A. 低于50微克/L
- B. 低于30微克/L

- C. 低于12微克/L ✓
- D. 低于100微克/L
- E. 低于5微克/L

答案：C | 理解 | 教材P545

解析：血清铁蛋白<12微克/L是诊断缺铁最特异的指标，反映贮存铁耗竭。SF 12-20微克/L提示贮存铁减少。

292. [batch014-M18-A1-004] 缺铁性贫血补铁治疗有效的指标是？

- A. 血红蛋白立即升高
- B. 网织红细胞5至10天达高峰 ✓
- C. 血清铁蛋白立即恢复
- D. 红细胞形态立选项
- E. 白细胞计数升高

答案：B | 理解 | 教材P546

解析：口服铁剂后网织红细胞5-10天达高峰（网织红细胞反应），是补铁有效的早期指标。血红蛋白约2周后开始升高。

293. [batch014-M18-A1-add-050] 口服铁剂治疗缺铁性贫血的疗程应持续到？

- A. Hb正常后立即停药
- B. Hb正常再服3至6个月 ✓
- C. 服用1个月即可
- D. 需终生服用铁剂
- E. 网织红升高后停药

答案：B | 记忆 | 教材P546

解析：铁剂需在Hb正常后继续3-6个月补足贮存铁（SF>50μg/L），否则易复发。

294. [batch014-M18-A1-add-051] 缺铁性贫血与慢性病贫血鉴别的关键指标是？

- A. 血红蛋白水平
- B. 血清铁蛋白水平 ✓
- C. MCV值
- D. 网织红细胞计数
- E. 白细胞计数

答案：B | 理解 | 教材P545

解析：缺铁贫SF<12μg/L；慢性病贫血SF正常或升高。SF是两者关键鉴别指标。

A2型题（2题）

295. [batch014-M18-A2-001] 女性，35岁，月经过多2年。面色苍白，血常规Hb=78g/L，MCV=72fl，血清铁蛋白=8微克/L。最可能的诊断是？

- A. 巨幼细胞性贫血
- **B. 缺铁性贫血** ✓
- C. 再生障碍性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 慢性病贫血

答案：B | 应用 | 教材P544-P546

解析：月经过多（慢性失血）+小细胞低色素性贫血（MCV低）+血清铁蛋白显著降低，符合缺铁性贫血。巨幼贫为大细胞性。

296. [batch014-M18-A2-002] 缺铁性贫血患者口服铁剂治疗4周后Hb无明显上升，最常见的原因是？

- A. 诊断错误
- B. 补铁剂量
- **C. 持续失血未控制** ✓
- D. 铁剂不耐受
- E. 需要注射铁剂

答案：C | 应用 | 教材P546

解析：补铁治疗无效最常见的原因是持续失血未控制（如持续月经过多、消化道出血），其次为服药依从性差或诊断错误。

A3型题（3题）

297. [batch014-A3-BL1-sub01] 该患者贫血的形态学分类是？

- A. 大细胞性贫血
- B. 正细胞性贫血
- **C. 小细胞低色素性贫血** ✓
- D. 单纯小细胞性贫血

- E. 溶血性贫血

答案：C | 应用 | 教材P544-P546

解析：MCV<80fl+MCHC<32%为小细胞低色素性贫血，常见病因为缺铁贫和地中海贫血。

298. [batch014-A3-BL1-sub02] 确诊首选的实验室检查是？

- A. 骨髓穿刺
- B. 血清铁蛋白+血清 ☒
- C. 血红蛋白电泳
- D. 叶酸和维生素B1
- E. 溶血全套

答案：B | 应用 | 教材P544-P546

解析：血清铁蛋白<12μg/L+血清铁降低+TIBC升高可确诊缺铁贫。骨髓穿刺用于不典型病例。

299. [batch014-A3-BL1-sub03] 口服铁剂治疗后，网织红细胞应何时达高峰？

- A. 24小时内
- B. 5至10天 ☒
- C. 2至3周
- D. 1个月
- E. 无需监测

答案：B | 应用 | 教材P544-P546

解析：口服铁剂后网织红细胞5-10天达高峰(网织红细胞反应)，是补铁有效的早期指标。Hb约2周后开始升高。

X型题 (1题)

300. [batch014-M18-X-001] 缺铁性贫血的实验室特征包括以下哪些？

- A. 血清铁降低
- B. 总铁结合力升高
- C. 血清铁蛋白降低
- D. 转铁蛋白饱和度降低
- E. 骨髓铁染色阴性

答案：ABCDE | 记忆 | 教材P545

解析：缺铁贫全套实验室特征：血清铁降低、总铁结合力升高、铁蛋白降低、转铁蛋白饱和度降低、骨髓可染铁消失。

M19 再生障碍性贫血（6题）

A1型题（5题）

301. [batch014-M19-A1-001] 再生障碍性贫血的主要发病机制是？

- A. 铁利用障碍
- **B. 造血干细胞缺陷** ✓
- C. 维生素缺乏
- D. 红细胞破坏过多
- E. 失血所致

答案：B | 记忆 | 教材P547-P548

解析：再障的主要发病机制为造血干细胞内在缺陷（种子学说），伴免疫异常（虫子学说）和造血微环境异常（土壤学说）。

302. [batch014-M19-A1-002] 再障患者外周血典型的表现为？

- A. 白细胞增多
- **B. 全血细胞减少** ✓
- C. 血小板增多
- D. 仅红细胞减少
- E. 仅血小板减少

答案：B | 记忆 | 教材P548

解析：再障特征为全血细胞减少（贫血、白细胞减少、血小板减少），骨髓增生减低，无异常细胞浸润。

303. [batch014-M19-A1-003] 年轻重型再障患者首选的根治性治疗是？

- A. 雄激素类药物
- B. 环孢素类药物
- **C. 异基因造血干细胞移植** ✓
- D. ATG加环孢
- E. 糖皮质激素

答案：C | 理解 | 教材P549-P550

解析：年轻重型再障（<40岁）有HLA相合同胞供者时，首选异基因造血干细胞移植。无供者则选ATG联合环孢素免疫抑制治疗。

304. [batch014-M19-A1-004] 确诊再障最有价值的检查是？

- A. 外周血涂片
- **B. 骨髓穿刺加活检** ✓
- C. 血清铁蛋白
- D. 叶酸维生素B12测定
- E. 溶血相关检查

答案：B | 理解 | 教材P548-P549

解析：骨髓穿刺+活检是确诊再障的金标准，表现为骨髓增生减低、造血组织减少、非造血细胞增多。外周血仅提示全血细胞减少。

305. [batch014-M19-A1-add-052] 再障需与哪种同为全血细胞减少的疾病鉴别？

- A. 急性白血病
- **B. 阵发性睡眠性** ✓
- C. 巨幼细胞性贫血
- D. MDS
- E. ITP

答案：B | 记忆 | 教材P549

解析：PNH可表现为全血细胞减少，通过CD55/CD59流式检测鉴别。

A2型题（1题）

306. [batch014-M19-A2-001] 青年男性，进行性面色苍白伴皮肤瘀斑。血常规三系减少，骨髓活检示增生极度减低，脂肪组织增多。诊断是？

- A. 急性白血病
- **B. 再生障碍性贫血** ✓
- C. 骨髓增生异
- D. 巨幼细胞性贫血
- E. 阵发性睡眠性血红蛋白

答案：B | 应用 | 教材P548-P549

解析：青年+全血细胞减少+骨髓增生极度减低+脂肪替代，是典型再障表现。白血病骨髓增生活跃且有原始细胞增多。

M20 MDS（8题）

A1型题（3题）

307. [batch014-M20-A1-001] 骨髓增生异常综合征（MDS）的特征性骨髓改变是？

- A. 骨髓增生极度活跃
- **B. 病态造血** ☒
- C. 骨髓纤维化
- D. 骨髓坏死
- E. 骨髓增生减低

答案：B | 记忆 | 教材P551-P552

解析：MDS的特征为病态造血（一系或多系），骨髓增生活跃或明显活跃但外周血减少（无效造血）。

308. [batch014-M20-A1-002] MDS国际预后评分系统（IPSS-R）最重要的预后因素是？

- A. 年龄
- **B. 骨髓原始** ☒
- C. 血红蛋白
- D. 血小板计
- E. 铁蛋白水

答案：B | 记忆 | 教材P553

解析：骨髓原始细胞比例是MDS预后最重要的因素，原始细胞越多预后越差。细胞遗传学异常也极为重要。

309. [batch014-M20-A1-add-053] MDS转化为AML的骨髓原始细胞阈值为？

- A. 大于
- B. 大于
- **C. 大于** ☒
- D. 大于
- E. 大于

答案：C | 理解 | 教材P552-P553

解析：原始细胞 $\geq 20\%$ 是MDS与AML分界线。EB-2为10-19%。

A2型题（1题）

310. [batch014-M20-A2-001] 老年男性，乏力半年。血常规示大细胞性贫血，骨髓增生活跃，三系病态造血，原始细胞占8%。诊断是？

- A. 再生障碍性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血
- C. MDS-EB ☒
- D. AML
- E. 慢性病贫血

答案：C | 应用 | 教材P552-P553

解析：大细胞贫血+骨髓活跃+三系病态造血+原始细胞8%（5-9%），符合MDS-EB-1（原RAEB-1）。原始细胞 $\geq 20\%$ 为AML。

B1型题（3题）

311. [batch014-B1-BL5-sub01] 骨髓增生减低，无病态造血，无原始细胞增多，属于？

- A. 再生障碍性贫血 ☒
- B. 骨髓增生异
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白
- D. 急性白血病
- E. 骨髓纤维化

答案：A | 理解 | 教材P547-P553

解析：AA为骨髓增生减低+无病态造血+无原始细胞增多，脂肪替代。

312. [batch014-B1-BL5-sub02] 骨髓增生活跃伴三系病态造血且原始细胞5-19%，属于？

- A. 再生障碍性贫血
- B. 骨髓增生异 ☒
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白
- D. 急性白血病
- E. 骨髓纤维化

答案：B | 理解 | 教材P547-P553

解析：MDS为增生活跃+病态造血+原始细胞可增多(但<20%)，外周血减少。

313. [batch014-B1-BL5-sub03] CD55和CD59阴性细胞克隆，酸溶血试验阳性，属于？

- A. 再生障碍性贫血
- B. 骨髓增生异
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白 ☒
- D. 急性白血病
- E. 骨髓纤维化

答案：C | 理解 | 教材P547-P553

解析：PNH为CD55/CD59阴性克隆+Ham试验阳性，可合并AA(AA-PNH综合征)。

X型题（1题）

314. [batch014-M20-X-001] 影响MDS预后的主要因素包括以下哪些？

- A. 骨髓原始细胞比例
- B. 血细胞减少程度
- C. 细胞遗传学异常
- D. 患者年龄
- E. 血清铁蛋白水平

答案：ABC | 理解 | 教材P553

解析：IPSS-R评分核心因素：骨髓原始细胞比例、血细胞减少程度、细胞遗传学异常。年龄和铁蛋白非核心预后因素。

M21 淋巴瘤（12题）

A1型题（6题）

315. [batch014-M21-A1-001] 霍奇金淋巴瘤最具特征性的病理细胞是？

- A. 朗格汉斯细胞
- B. Reed-S ☒
- C. 泡沫细胞
- D. 异型淋巴细胞
- E. 浆细胞

答案：B | 记忆 | 教材P556-P557

解析：R-S细胞（镜影细胞）是霍奇金淋巴瘤的特征性病理细胞，来源于B淋巴细胞，表达CD30和CD15。

316. [batch014-M21-A1-002] 淋巴瘤Ann Arbor分期中，横膈两侧淋巴结受累属于？

- A. I期
- B. II期
- **C. III期** ✓
- D. IV期
- E. 局限期

答案：C | 记忆 | 教材P558

解析：III期为横膈两侧淋巴结区域均受累。I期累及单一淋巴结区，II期累及横膈同侧两个以上区域，IV期为弥漫性结外器官受累。

317. [batch014-M21-A1-003] 非霍奇金淋巴瘤最常见的病理类型是？

- A. 滤泡性淋巴瘤
- **B. 弥漫大B细胞淋巴瘤** ✓
- C. 套细胞淋巴瘤
- D. 边缘区淋巴瘤
- E. 外周T细胞淋巴瘤

答案：B | 记忆 | 教材P559

解析：弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）是NHL最常见的类型，约占30-40%。滤泡性淋巴瘤为第二常见。

318. [batch014-M21-A1-004] 淋巴瘤B症状不包括以下哪项？

- A. 不明原因发热超过
- B. 夜间盗汗
- C. 6个月体重下降超
- **D. 皮肤瘙痒** ✓
- E. 反复感染非B症状

答案：D | 记忆 | 教材P557

解析：B症状为：不明原因发热 $>38^{\circ}\text{C}$ 、盗汗、6个月内体重下降 $>10\%$ 。皮肤瘙痒曾为HD的B症状之一但现标准中已不单独列入。反复感染非B症状。

319. [batch014-M21-A1-add-054] 霍奇金淋巴瘤ABVD方案中B代表的药物是？

- A. 博来霉素 ☒
- B. 长春新碱
- C. 依托泊苷
- D. 环磷酰胺
- E. 阿糖胞苷

答案：A | 记忆 | 教材P558

解析：ABVD：A阿霉素、B博来霉素、V长春碱、D达卡巴嗪。HL标准方案。

320. [batch014-M21-A1-add-055] 以下哪种属于惰性非霍奇金淋巴瘤？

- A. 弥漫大B细胞淋巴瘤
- B. 滤泡性淋巴瘤 ☒
- C. 套细胞淋巴瘤
- D. Burkitt淋巴瘤
- E. 淋巴母细胞淋巴瘤

答案：B | 记忆 | 教材P559-P560

解析：滤泡性淋巴瘤为惰性，进展缓慢。其他均为侵袭性或高度侵袭性。

A2型题（1题）

321. [batch014-M21-A2-001] 男性，60岁，发热、盗汗、体重下降3个月。颈部及腹股沟可触及多个肿大淋巴结。淋巴结活检示弥漫大B细胞淋巴瘤。LDH显著升高。分期为？

- A. I期
- B. II期
- C. III期 ☒
- D. IV期
- E. 局限期

答案：C | 应用 | 教材P558-P559

解析：颈部+腹股沟淋巴结受累（横膈两侧）+B症状+LDH升高，属于Ann Arbor III期B。NHL最常见类型为弥漫大B细胞淋巴瘤。

A3型题（2题）

322. [batch014-A3-BL5-sub01] 该患者的Ann Arbor分期为？ 还需哪些检查？

- A. I期不需进一步检查
- **B. 至少III期** ☒
- C. II期仅需胸部CT
- D. IV期仅需骨髓检查
- E. 局限期无选项

答案：B | 应用 | 教材P556-P560

解析：颈部(横膈一侧)淋巴结+LDH升高+B症状，需行PET-CT和骨髓活检确定准确分期以指导治疗。

323. [batch014-A3-BL5-sub02] 该类型的标准一线化疗方案是？

- A. ABVD方案
- **B. R-CHOP方案** ☒
- C. Hyper-CVAD方案
- D. CHOP方案
- E. 单用利妥昔单抗

答案：B | 应用 | 教材P556-P560

解析：DLBCL标准一线方案为R-CHOP(利妥昔单抗+环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松)，治愈率约60%。ABVD用于HL。

B1型题 (3题)

324. [batch014-B1-BL4-sub01] Reed-Sternberg细胞为其特征性病理细胞，属于？

- **A. 霍奇金淋巴瘤** ☒
- B. 弥漫大B细胞淋巴瘤
- C. 滤泡性淋巴瘤
- D. Burkitt淋巴瘤
- E. 套细胞淋巴瘤

答案：A | 记忆 | 教材P556-P560

解析：R-S细胞(CD30+CD15+)是HL的特征性肿瘤细胞。

325. [batch014-B1-BL4-sub02] NHL中最常见的侵袭性类型，CD20阳性，属于？

- A. 霍奇金淋巴瘤

- **B. 弥漫大B细胞淋巴瘤** ✓
- C. 滤泡性淋巴瘤
- D. Burkitt淋巴瘤
- E. 套细胞淋巴瘤

答案：B | 记忆 | 教材P556-P560

解析：DLBCL是最常见NHL(30-40%)，侵袭性强但R-CHOP方案可治愈约60%。

326. [batch014-B1-BL4-sub03] 惰性淋巴瘤，t(14;18)致BCL-2过表达，属于？

- A. 霍奇金淋巴瘤
- B. 弥漫大B细胞淋巴瘤
- **C. 滤泡性淋巴瘤** ✓
- D. Burkitt淋巴瘤
- E. 套细胞淋巴瘤

答案：C | 记忆 | 教材P556-P560

解析：滤泡性淋巴瘤为惰性NHL，t(14;18)(q32;q21)致BCL-2重排。

M22 白血病（14题）

A1型题（6题）

327. [batch014-M22-A1-001] 急性淋巴细胞白血病免疫分型中，B-ALL最常表达的标志是？

- A. CD3阳性
- **B. CD19阳性** ✓
- C. CD13阳性
- D. CD33阳性
- E. MPO阳性

答案：B | 记忆 | 教材P565-P566

解析：B-ALL表达B细胞标志CD19、CD10、CD22等。CD3为T细胞标志，CD13/CD33/MPO为髓系标志。

328. [batch014-M22-A1-002] 慢性粒细胞白血病特征性的细胞遗传学异常是？

- A. t(8;21)
- B. t(15;17)

- C. t(9;22)费城染色体 ☒
- D. inv(16)
- E. 11q23重排

答案：C | 记忆 | 教材P570-P571

解析：t(9;22)(q34;q11)形成BCR-ABL融合基因（费城染色体），是CML特征性遗传学异常。t(15;17)见于APL，t(8;21)和inv(16)见于AML。

329. [batch014-M22-A1-003] 慢性粒细胞白血病慢性期首选的靶向治疗药物是？

- A. 羟基脲
- B. 干扰素
- C. 伊马替尼 ☒
- D. 阿糖胞苷
- E. 环磷酰胺

答案：C | 理解 | 教材P571-P572

解析：伊马替尼（第一代TKI）是CML慢性期的一线治疗，靶向BCR-ABL融合蛋白的酪氨酸激酶活性。耐药者可用二代或三代TKI。

330. [batch014-M22-A1-004] 急性早幼粒细胞白血病（APL）最严重的并发症是？

- A. 严重感染
- B. 中枢神经系统浸润
- C. DIC出血 ☒
- D. 睾丸浸润
- E. 高白细胞淤滞

答案：C | 理解 | 教材P567-P568

解析：APL极易并发DIC导致严重出血，是早期死亡的主要原因。维A酸和砷剂治疗可显著改善预后。

331. [batch014-M22-A1-005] 急性淋巴细胞白血病诱导缓解化疗的核心药物是？

- A. 伊马替尼
- B. 长春新碱加泼 ☒
- C. 羟基脲
- D. 干扰素
- E. 来那度胺

答案：B | 理解 | 教材P566-P567

解析：ALL诱导缓解方案（如VDLP方案）核心包括长春新碱、蒽环类、糖皮质激素和门冬酰胺酶。伊马替尼用于Ph+ALL和CML。

332. [batch014-M22-A1-add-056] 慢性淋巴细胞白血病特征性免疫表型是？

- A. CD3加CD8阳性
- **B. CD5加CD23阳性** ✓
- C. CD13加CD33阳性
- D. CD10加CD19阳性
- E. CD34加CD117阳性

答案：B | 记忆 | 教材P573

解析：CLL：CD5+CD23+CD19+CD20(dim)。套细胞为CD5+CD23-。

A2型题（3题）

333. [batch014-M22-A2-001] 男性，45岁，发热、牙龈出血1周。血常规：

WBC=35×10⁹/L，Hb=68g/L，PLT=25×10⁹/L。骨髓涂片原始细胞占65%，MPO阳性。诊断是？

- A. 急性淋巴细胞白血病
- **B. 急性髓系白血病** ✓
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 骨髓增生异常
- E. 再生障碍性贫血

答案：B | 应用 | 教材P564-P566

解析：外周血高白细胞+贫血+血小板减少+骨髓原始细胞大于等于20%且MPO阳性，符合AML诊断。ALL为MPO阴性。

334. [batch014-M22-A2-002] 男童，5岁，发热骨痛2周。WBC升高，Hb降低，PLT降低。骨髓原始细胞92%，MPO阴性，CD19阳性。诊断是？

- A. AML
- **B. B-ALL** ✓
- C. T-ALL
- D. CML
- E. MDS

答案：B | 应用 | 教材P565-P566

解析：儿童+原始细胞>20%+MPO阴性排除AML+CD19阳性（B细胞标志），符合B-ALL。ALL是儿童最常见的白血病类型。

335. [batch014-M22-A2-add-057] 确诊急性早幼粒细胞白血病后应立即开始哪种治疗？

- A. 常规联合化疗
- **B. 全反式维A酸** ✓
- C. 造血干细胞移植
- D. 放射治疗
- E. 免疫治疗

答案：B | 应用 | 教材P567-P568

解析：APL确诊后应立即ATRA诱导分化并防治DIC。ATRA加砷剂使APL可治愈。

A3型题（2题）

336. [batch014-A3-BL2-sub01] 确诊及分型最重要的检查是？

- A. 外周血涂片
- **B. 骨髓穿刺加免疫分型** ✓
- C. 胸部CT检查项目
- D. 淋巴结活检
- E. PET-CT检查

答案：B | 应用 | 教材P564-P567

解析：骨髓穿刺+流式免疫分型是确诊AL和确定亚型(AML/ALL)的金标准，可同时行细胞遗传学和分子学检测。

337. [batch014-A3-BL2-sub02] 若MPO阳性且Auer小体可见，诊断为？

- A. 急性淋巴细胞白血病
- **B. 急性髓系白血病** ✓
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 骨髓增生异常
- E. 再生障碍性贫血

答案：B | 应用 | 教材P564-P567

解析：MPO阳性+Auer小体(AML特征)+原始细胞>20%=AML。ALL为MPO阴性。

B1型题 (3题)

338. [batch014-B1-BL2-sub01] MPO阳性且Auer小体可见，免疫表型CD13+CD33+，属于？

- A. AML伴t(8;21) ☒
- B. APL伴t(15;17)
- C. B-ALL伴CD19阳性
- D. T-ALL伴CD3阳性
- E. CML伴t(9;22)

答案：A | 应用 | 教材P565-P573

解析：MPO+Auer小体+CD13/CD33是AML(尤其M2伴t(8;21))的典型特征。

339. [batch014-B1-BL2-sub02] 易并发DIC且对全反式维A酸治疗敏感，属于？

- A. AML伴t(8;21)
- B. APL伴t(15;17) ☒
- C. B-ALL伴CD19阳性
- D. T-ALL伴CD3阳性
- E. CML伴t(9;22)

答案：B | 应用 | 教材P565-P573

解析：APL(M3)以t(15;17)PML-RARA融合基因为特征，极易并发DIC，对ATRA敏感。

340. [batch014-B1-BL2-sub03] 费城染色体阳性且BCR-ABL融合基因阳性，属于？

- A. AML伴t(8;21)
- B. APL伴t(15;17)
- C. B-ALL伴CD19阳性
- D. T-ALL伴CD3阳性
- E. CML伴t(9;22) ☒

答案：E | 应用 | 教材P565-P573

解析：Ph染色体t(9;22)和BCR-ABL是CML的特征，TKI靶向治疗有效。

M23 过敏性紫癜 (8题)

A1型题（4题）

341. [batch014-M23-A1-001] 过敏性紫癜最常累及的器官是？

- A. 肾脏
- B. 关节
- **C. 皮肤** ✓
- D. 消化道
- E. 心脏

答案：C | 记忆 | 教材P575

解析：过敏性紫癜最常累及皮肤（100%），表现为双下肢对称性可触性紫癜。肾脏受累（紫癜性肾炎）是最重要的远期并发症。

342. [batch014-M23-A1-002] 过敏性紫癜与ITP鉴别的关键点是？

- A. 出血部位
- **B. 血小板计数正** ✓
- C. 白细胞计数正
- D. 贫血程度
- E. 年龄分布

答案：B | 理解 | 教材P575-P576

解析：过敏性紫癜血小板计数正常（非血小板减少性紫癜），而ITP为血小板减少性紫癜。过敏性紫癜为IgA介导的白细胞碎裂性血管炎。

343. [batch014-M23-A1-003] 过敏性紫癜最需要警惕的远期并发症是？

- A. 皮肤溃疡
- **B. 紫癜性肾炎** ✓
- C. 肠穿孔
- D. 心肌炎
- E. 脑出血

答案：B | 理解 | 教材P575-P576

解析：紫癜性肾炎（IgA肾病型）是过敏性紫癜最严重的远期并发症，可进展为慢性肾衰竭。需定期监测尿常规。

344. [batch014-M23-A1-add-058] 过敏性紫癜单纯皮肤型首选治疗是？

- A. 糖皮质激素
- **B. 抗组胺药对症治疗** ☒
- C. 免疫抑制剂
- D. 血浆置换
- E. 抗感染治疗

答案：B | 理解 | 教材P576

解析：单纯皮肤型以对症治疗为主，多数可自愈。关节型和腹痛型可用激素。

A2型题（1题）

345. [batch014-M23-A2-001] 男孩，7岁，双下肢对称性紫癜伴踝关节肿痛腹痛。血小板计数正常。最可能的诊断是？

- A. ITP
- **B. 过敏性紫癜** ☒
- C. 急性白血病
- D. 血友病
- E. 脑膜炎球菌败

答案：B | 应用 | 教材P575

解析：儿童+双下肢对称性可触性紫癜+关节痛+腹痛+血小板正常，是过敏性紫癜（Henoch-Schonlein）混合型的典型表现。

B1型题（3题）

346. [batch014-B1-BL3-sub01] 血小板计数正常，双下肢对称性可触性紫癜，属于？

- **A. 过敏性紫癜** ☒
- B. ITP
- C. TTP
- D. DIC
- E. 血友病A

答案：A | 应用 | 教材P575-P584

解析：过敏性紫癜PLT正常+可触性紫癜+关节痛+腹痛+IgA沉积。

347. [batch014-B1-BL3-sub02] 血小板减少但凝血正常，骨髓巨核细胞增多伴成熟障碍，属于？

- A. 过敏性紫癜
- **B. ITP** ☒
- C. TTP
- D. DIC
- E. 血友病A

答案：B | 应用 | 教材P575-P584

解析：ITP为PLT减少+凝血正常+骨髓巨核细胞成熟障碍(产板不良)。

348. [batch014-B1-BL3-sub03] 血小板减少伴微血管病性溶血和神经精神症状，属于？

- A. 过敏性紫癜
- B. ITP
- **C. TTP** ☒
- D. DIC
- E. 血友病A

答案：C | 应用 | 教材P575-P584

解析：TTP五联征：PLT减少+微血管病性溶血+神经症状+发热+肾损害。

M24 ITP（8题）

A1型题（4题）

349. [batch014-M24-A1-001] 免疫性血小板减少症（ITP）的主要发病机制是？

- A. 骨髓巨核细胞生成
- **B. 抗血小板抗体介导** ☒
- C. 脾功能亢进
- D. DIC消耗
- E. 药物抑制

答案：B | 记忆 | 教材P577

解析：ITP是因抗血小板自身抗体（主要为IgG型）致敏血小板，在脾脏被单核巨噬细胞系统破坏。骨髓巨核细胞代偿性增多。

350. [batch014-M24-A1-002] 成人ITP的一线治疗是？

- A. 利妥昔单抗

- B. 脾切除
- **C. 糖皮质激素** ✓
- D. 环孢素
- E. 达那唑

答案：C | 理解 | 教材P578-P579

解析：糖皮质激素（泼尼松1mg/kg/d）是成人ITP的标准一线治疗。脾切除和利妥昔单抗为二线选择。

351. [batch014-M24-A1-003] 成人ITP启动治疗的指征是血小板计数低于？

- A. $100 \times 10^9/L$
- B. $50 \times 10^9/L$
- **C. $30 \times 10^9/L$** ✓
- D. $10 \times 10^9/L$
- E. 任何时候均可治疗

答案：C | 理解 | 教材P578

解析：成人ITP一般 $PLT < 30 \times 10^9/L$ 或有明显出血时启动治疗。 $PLT > 30$ 且无出血者可观察。 $PLT < 10$ 为重症需紧急治疗。

352. [batch014-M24-A1-add-059] 儿童ITP与成人ITP的主要区别是？

- **A. 儿童多为急性自限性** ✓
- B. 儿童血小板更低
- C. 儿童出血更严重
- D. 儿童需要脾切除
- E. 儿童对激素无效

答案：A | 记忆 | 教材P577

解析：儿童ITP多急性起病80%在6个月内自愈，与病毒感染有关。成人ITP多慢性。

A2型题（1题）

353. [batch014-M24-A2-001] 女性，28岁，皮肤瘀斑1周。 $PLT = 15 \times 10^9/L$ ，骨髓巨核细胞增多伴成熟障碍。ANA阴性，HIV阴性。最可能的诊断是？

- A. 过敏性紫癜
- **B. 免疫性血小板** ✓

- C. 再生障碍性贫血
- D. 白血病
- E. 系统性红斑狼

答案：B | 应用 | 教材P577-P578

解析：青年女性+血小板显著减少+骨髓巨核细胞增多伴成熟障碍（产板不良）+ANA阴性排除SLE，符合ITP诊断。

A3型题（2题）

354. [batch014-A3-BL3-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 过敏性紫癜
- B. ITP ☒
- C. TTP
- D. DIC
- E. 再生障碍性贫血

答案：B | 应用 | 教材P577-P579

解析：年轻女性+孤立PLT减少(无贫血和WBC减少)+ANA阴性排除SLE+脾不大，符合ITP。

355. [batch014-A3-BL3-sub02] 首选的初始治疗是？

- A. 紧急脾切除
- B. 糖皮质激素 ☒
- C. 利妥昔单抗
- D. TPO受体激动剂
- E. 观察等待

答案：B | 应用 | 教材P577-P579

解析：PLT=12<30且有出血症状，应启动治疗。糖皮质激素(泼尼松1mg/kg/d)是ITP标准一线治疗。

X型题（1题）

356. [batch014-M24-X-001] ITP的二线治疗包括以下哪些？

- A. 脾切除术
- B. 利妥昔单抗

- C. 血小板生成素受体
- D. 口服铁剂
- E. 免疫抑制剂

答案：ABCE | 理解 | 教材P578-P579

解析：ITP二线治疗含脾切除、利妥昔单抗、TPO-RA（如艾曲泊帕）和免疫抑制剂（如环孢素、硫唑嘌呤）。铁剂用于缺铁性贫血而非ITP。

M25 DIC（8题）

A1型题（4题）

357. [batch014-M25-A1-001] DIC最关键的发病环节是？

- A. 血小板减少
- **B. 凝血系统过度激活** ☒
- C. 抗凝物质增
- D. 纤溶亢进加重出血
- E. 血管壁损伤

答案：B | 理解 | 教材P582-P583

解析：DIC的核心是各种病因导致凝血系统过度激活，广泛微血栓形成，消耗凝血因子和血小板→出血。继发纤溶亢进加重出血。

358. [batch014-M25-A1-002] 诊断DIC最敏感的实验室指标是？

- A. PT延长
- B. APTT延长
- **C. D-二聚体显著升** ☒
- D. 纤维蛋白原降低
- E. 血小板减少

答案：C | 记忆 | 教材P583

解析：D-二聚体（或FDP）显著升高是DIC最敏感的指标，反映继发性纤溶亢进。PLT减少和PT/APTT延长也为DIC的表现但不特异。

359. [batch014-M25-A1-003] DIC治疗中最根本的措施是？

- A. 输注血小板
- B. 肝素抗凝

- C. 治疗原发病 ☒
- D. 输注新鲜冰冻血浆
- E. 抗纤溶药物

答案：C | 理解 | 教材P583-P584

解析：治疗原发病是DIC最根本的措施（如抗感染、产科处理、肿瘤治疗等），去除诱因后DIC可自行缓解。支持治疗为辅助手段。

360. [batch014-M25-A1-add-060] DIC与TTP鉴别时，更支持TTP的是？

- A. PT和APTT显著延长
- B. ADAMTS13活性显著降低 ☒
- C. 纤维蛋白原显著降低
- D. D-二聚体显著升高
- E. 血小板减少伴凝血异常

答案：B | 理解 | 教材P584

解析：TTP因ADAMTS13活性<10%导致vWF不能裂解。TTP的PT/APTT一般正常。

A2型题（1题）

361. [batch014-M25-A2-001] 产妇产后大出血，出现皮肤瘀斑、穿刺部位渗血。

PLT=35x10⁹/L，PT=22秒，APTT=60秒，纤维蛋白原=0.8g/L，D-二聚体显著升高。诊断是？

- A. 单纯血小板减少
- B. DIC ☒
- C. 维生素K缺乏
- D. 肝素过量
- E. 原发性纤溶亢

答案：B | 分析 | 教材P582-P583

解析：产科大出血（DIC常见病因）+血小板减少+PT和APTT显著延长+低纤维蛋白原+D-二聚体显著升高，符合急性DIC的典型实验室特征。

A3型题（2题）

362. [batch014-A3-BL4-sub01] 该患者最可能的诊断是？

- A. 稀释性凝血障碍

- B. 弥散性血管内凝血 ☒
- C. 原发性纤溶亢进
- D. 肝素过量
- E. 维生素K缺乏

答案：B | 分析 | 教材P582-P584

解析：产科大出血+PLT降低+PT/APTT延长+Fg降低+D-二聚体显著升高=急性DIC典型五联征。

363. [batch014-A3-BL4-sub02] 最根本的治疗措施是？

- A. 输注血小板
- B. 肝素抗凝
- C. 积极处理原发病加 ☒
- D. 抗纤溶药物
- E. 新鲜冰冻血浆

答案：C | 应用 | 教材P582-P584

解析：DIC治疗根本在于处理原发病(产科止血/抗感染等)。支持治疗(PLT/FFP等)为辅助手段。肝素和抗纤溶药仅用于特定情况。

X型题（1题）

364. [batch014-M25-X-001] DIC的实验室诊断依据包括以下哪些？

- A. 血小板进行性下降
- B. PT和APTT延长
- C. 纤维蛋白原进行性降低
- D. D-二聚体显著升高
- E. 外周血病变

答案：ABCDE | 理解 | 教材P583

解析：DIC实验室特征：PLT降低、PT/APTT延长、Fg降低、FDP/D-二聚体升高、外周血可见裂红细胞（微血管病性溶血）。全部选项均为DIC表现。